1. AMPLÍO DENUNCIA – APORTO Y OFREZCO PRUEBA. SOLICITO.

Señor Juez:

NICOLAS HORACIO KOSCIUK, DNI 28.731.776, de nacionalidad argentina, de profesión programador, por derecho propio, constituyendo domicilio a los efectos de la presente en Mozart 610, Ciudad Autonoma de Buenos Aires y domicilio electrónico en nhk@justiciaparamargarita.ar me presento y respetuosamente digo:

2. OBJETO

Vengo a AMPLIAR la Denuncia realizada el día 4 de marzo de 2022, en razón de los HECHOS y PRUEBA que seguidamente manifestaré.

Y APORTAR las pruebas que tengo en mi poder, en relación de los hechos denunciados/ampliados; como también a OFRECER PRUEBA que se halla en poder del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la CIUDAD DE BUENOS AIRES.

2.1. AMPLIO

La denuncia realizada el 4 de marzo de 2022 fue consecuencia de la sospechosa aparición de la denuncia MPF654300, la cual se ampliará en la sección 3.12.

Los puntos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 de la denuncia del 4 de marzo de 2022 serán ampliados en la sección 3.4. El punto 3.5 en la seccion 3.11. El punto 3.6 en la sección 3.12.

En cuanto a la ampliación de la denuncia diría que:

El 25 de marzo de 2020 me expulsaron irregularmente del Hospital Piñero de CABA para poder dejar morir de hambre a mi madre sin que haya testigos. Para justificar la expulsión fue necesario adulterar la Historia Clinica. Ver Sección 3.1.8 y **Prueba**

4.1.8.

La forma elegida habría sido dejar de suministrarle alimento: habiendo expulsado al único familiar, dependiendo de terceros para comer a partir del cambio a la Unidad 1, requiriendo de un profesional dedicado para el uso del aspersonr de flema, poniendole sonda con un mes de retraso, sabiendo que el registro de comidas no figura en la Historia Clínica y haciendo desaparecer las hojas de enfermería donde si se podría determinar si comía o no.

Parece ser que mientras la dejaban morir en Clínica Médica, en la Unidad hubo un contagio de COVID lo que motivó el vaciamiento y cambio de personal. Y es quizá por este hecho, y el movimiento a una sala de COVID que nunca más me permitieron ingresar, para que no me entere de ese cambio.

Suponiendo ese movimiento a Sala COVID, eso explicaria el faltante de enfermeria, no podian dejar mitad en una sala y mitad en la otra, revelando el contagio intrahospitalario. Y lo más sorprendente sería, que los médicos siguieron haciendo la historia clinica como si no se la hubiese movido.

A la historia clínica incautada le faltan como mínimo los ultimos 46 de enfermería, con lo cual no sabemos si comía o si le suministraban los medicamentos.

La eliminación de esas partes, por lógica, debió haber sido hecha por el Hospital, por el MPF o por el Hospital **en coordinación** con el MPF.

Mis sospechas se inclinan más hacia el arreglo MPF - Hospital en base a que el MPF decidió mantener ajeno al Hospital, investigar me a mi como pretexto para impedir la querella y evitar así que tenga acceso a la Historia Clínica y a la posibilidad de pedir la autopsia.

Pareciera como que en el MPF se hubiesen puesto de acuerdo en no mencionar que falta casi un cuarto de la Historia Clínica.

El MPF llegó a decir que no importa si faltan partes, con lo que podrían eliminar lo que queda con total impunidad.

Quizá el verdadero motivo de eliminar partes sea que verdaderamente haya habido un contagio intrahospitalario y sea eso lo que se intenta encubrir puesto que podrían

ser muchas más las víctimas.

Respecto al faltante de partes de la Historia Clínica que se comenta en detalle en el Punto 3.2, uno no puede saber si la paciente era atentida por los médicos (no hay indicaciones), si era controlada o si le era suministrada la medicación adecuada en tiempo y forma. Mucho menos si era alimentada y como era realizada tal proeza.

De la inspección de los laboratorios, uno podría suponer que dejaron de suministrarle *ranitidina* (en casa tomaba Sintron por estar anticoagulada) y eso es lo que explicaría que el RIN haya pasado de alrededor de 1 a casi 3 en los últimos días.

2.1.1. MPF462972

La denuncia MPF462972 se archivo únicamente usando como prueba la historia clínica y con partes faltantes que hace sospechar aún peores atrocidades.

Entre las irregularidades de la causa:

- no se me entrevistó ni se me permitió aportar pruebas, pese al proveído del Fiscal en pagina 35 del PDF
- se me intento declarar insano
- el acceso a la Historia Clínica estuvo supeditado a ser querellante, pese a que se incautó el 18 de mayo, se dio copia recién el 13 de julio
- se le negó el expediente al abogado el 27 de julio diciendo que se le envió una vez, pagina 230 del PDF
- se filtraron mensajes mios al médico. La URL que envié al fiscal el *lun 8/6/2020 17:31* (Página 97 del PDF) fue aportada por el médico en la declaración del dia 9 de junio (al dia siguiente) tal como puede verse en la pagina 71 del PDF)
- se archivo el 31 de julio, 4 días de que la Fiscalía se enterase que el abogado no tenia copias

- pese a que el médico que me expulso declaro que “dejó de venir por haber comenzado la cuarentena” - Página 71 del PDF- y que el Director no tenia inconvenientes a que yo ingrese informe de la defensoría, el Fiscal llegó a la conclusión de que fui bien expulsado -no se sabe por quien- y pone como excusa a la mujer inventada, la de apellido Lizardo

3. HECHOS

3.1. Cronología pre-denuncia

3.1.1. Diciembre de 2019

Durante diciembre (creo) se hicieron los trámites para intentar conseguir un cuidador domiciliario de PAMI. La idea era que yo pueda salir a trabajar. Ante la negativa de PAMI del cuidador es que aproveché el 19 de enero para conseguir. La idea nunca fue geriatrizar a alguien que puede estar en casa.

3.1.2. 27 de diciembre de 2019

Se nos traslada desde casa a mi madre y a mi a la Guardia del Piñero, en base a los laboratorios se le diagnostica infección urinaría. Nos dan el alta y la orden para retirar antibióticos en la farmacia del Hospital. No recuerdo el nombre del remedio pero era para un tratamieneto de 14 días.

El tratamiento no funcionó. Un médico de PAMI dijo que el problema era pulmonar y recetó un remedio que hizo efecto los primeros días. Faltaría consultar con PAMI para saber fecha, remedio y lo informado por el médico.

3.1.3. 19 de enero de 2020

Nuevo ingreso a la Guardia del Piñero, por el mismo problema que el 27 de diciembre, sin diagnostico alguno intentan darnos de alta.

Siendo que la situación era casi la misma que en la anterior visita, ahora agravada por el paso del tiempo, me niego al alta y me retiro del lugar. Le dejo mi número al de seguridad.

Me llaman dos veces durante la noche desde el Hospital. Al prometerme que el traslado lo haría PAMI[1] voy al Hospital, pero era mentira, no habían llamado a PAMI por lo que me vuelvo a retirar.

3.1.4. Internación en Guardia

Luego de unos días en internación de Guardia por fin deciden encontrarle la neumonía (supongo que es lo que tenía desde el 27 de diciembre). Visto desde fuera, parece que el tratamiento con el Linezolid hizo efecto.

3.1.5. 28 de febrero 2020

Se la veia bien, aunque desorientada como siempre que pasaba muchos dias internada, ver **Prueba 4.1.1**.

Recuerdo un video, que no puedo encontrar, donde se preocupaba porque no veía al gatito blanco y pensaba que se había perdido. Obviamente el gatito estaba en casa.

3.1.6. 18 de marzo 2020

Del 12 al 18 de marzo mi madre estuvo compartiendo sala con una mujer su acompañante, que lamentablemente abría la ventana en dias de frio sin que ningun enfer-

[1] No quería retirarla arrastrandola como tuve que hacer la primera vez

mero le dijera nada.

El 18 de marzo le dan el alta, llevandose accidental o intencionalmente la Biblia de mi madre (eso ya no importa). Desde ese día mi madre queda sola en la sala.

¿Si mi mamá tenía KPC y debía estar aislada (es el cartelito rojo que se ve en la puerta en el video del 25 de marzo), por qué arriesgaban la salud de la otra paciente?

3.1.7. 24 de marzo 2020

Un dia como cualquier otro, pero aparece la novedad del aparato aspersonr de flema, voy a enfermería y me dicen que vaya a buscar por el hospital a alguien que lo sepa usar, no consegui a nadie y al volver no me dejan ingresar porque dicen “terminó el horario de visitas", pese a que yo tenía el permiso para las 4 comidas.

De ese paseo por el Hospital saqué una foto en la Guardia que relacionaba la flema con el COVID, ver **Prueba 4.3.3**.

Yo ya había ingresado y tenía mis cosas dentro, tuve que hacer que llamen al de seguridad con quien al menos se podía razonar. Me dejan sacar mis cosas y me hacen ir, no les importó si mi madre comió. El de seguridad dice que para “calmar los ánimos” mejor no vaya a la noche. Uno de los enfermeros dice que no es responsabilidad de ellos alimentar a los pacientes, mientras que el otro, Mario, dice que se va a ocupar.

No comió al mediodía y no comería a la noche.

3.1.8. 25 de marzo de 2020

Con el apuro de que me vaya, el 24 me dejé el cargador del celular en la habitación. Tengo el video de la pequeña investigación. Video 4.1.5. Pensé que quizá en lugar de robarselo, simplemente lo tiraron a la basura y voy a ver. Solo encontré la comida intacta de la noche anterior.

Mi primera reacción fue pedir al médico que venga para comentarle que no me dejaron ingresar el día anterior y que tiraron la comida a la basura, viendo que no venia y

antes de que pase personal de limpieza a retirar la bolsa, decido rescatar la evidencia y puse ambas bandejitas sobre la mesa. Video 4.1.6.

Mientras espero veo que pasa el médico y se va de la sala, había una reunión de médicos en el pasillo, afuera de la Unidad 4, era el primer día luego del fin de semana y 2 feriados. El médico estaba con el celular (cosa que hago mención en el video) y al levantar la vista me ve, me dice si me puedo ir, respondo fuerte que no y me miran todos los presentes, dije algo como “quería comentar que de la Unidad 1 me hacen ir por tonterías a la guardia, si quieren que me contagie de algo y contagie a toda la unidad lo van a lograr. Nada más". Di media vuelta y me volví a la sala. Supongo que esto hizo que el médico vuelva más alterado de lo normal.

Esperando que venga el médico, pasa la Jefa de Enfermería quien me dice que tire eso, le digo que no puedo hasta que lo vea el médico. Amenaza con llamar al médico, por mi mejor, era lo que estaba esperando hace hora y media. Video 4.1.7.

Finalmente a las 12:35 aparece el Dr. Schinocca tal como se ve en el video 4.1.8.

La transcripción del diálogo es:

> Seguridad: Buenas
>
> Yo: Buenas, ¿qué hora tienen?
>
> Schinocca: ¿qué? ¿qué te pasa?
>
> Yo: Nada, yo no lo llame a usted.
>
> Schinocca: No, pero vos llamaste a la enfermera para mostrarle la comida ¿que sacaste de dónde?
>
> Yo: Del coso rojo,
>
> Schinocca: del tacho de basura.
>
> Yo: la bolsa rosa (sic)
>
> Schinocca: ¿Vos queres contaminar la sala y cagarnos la vida a todos? En dos minutos te hago meter en cana a vos. Vos te vas a curar rápido.
>
> Yo: bueeeeno.
>
> Schinocca: Asi que te retiras de la sala y anda a hacer la queja que quieras, que yo ya estoy preparando (no entiendo), asi que inmediatamente

te retiras. Si vos te pensas que me vas a contaminar el servicio vos, cuando hay gente que se esta muriendo...

Yo: si usted estaba boludeando con el celular (en la reunion esa en el pasillo) en la reunión.

Schinocca: Yo estaba en una reunion de medicos, flaco.

Yo: estaba con el celular

Schinocca: Cortala, vos te hago una nota por insania, acá no me entrás más, se terminó.

Yo: bueno, listo, asi queda mi madre, cualquier cosa que pase, eh..., es responsabilidad del médico, eh...

Pese a lo que se ve en el video, el médico tuvo *otra versión de los hechos* que quedó plasmada en la historia clínica tal como se ve en *Página 123 del archivo* ***HistoriaClinica.pdf*** y que dice:

Dejamos constancia que quien refiere ser su hijo presentas conductas inapropiadas en la sala. Conducta querellante con el personal médico.

En el día de la fecha retira de el recipiente de residuos patogénicos de la habitación la comida de la internada distribuyendola por la habitación sobre camas y demás

Ante esta situación se llama a personal de seguridad quienes se presentan de inmediato y retiran al referido.

Me comunico con la Jefa de Departamento informando la situación para que tome conocimiento.

Enfermería presente en el momento de dicho acto. Por lo que vuelvo en su report lo acontecido. Dada la conducta desadaptada se sugiere limitar el ingreso.

¿Será normal escribir tantas mentiras aún cuando no hay ni siquiera conflictos con el familiar para cubrirse de lo que pueda pasar?

A partir de esta fecha considero la Historia Clínica adulterada, incluyendo los registros de otros medicos que siguieron con las mentiras de este médico.

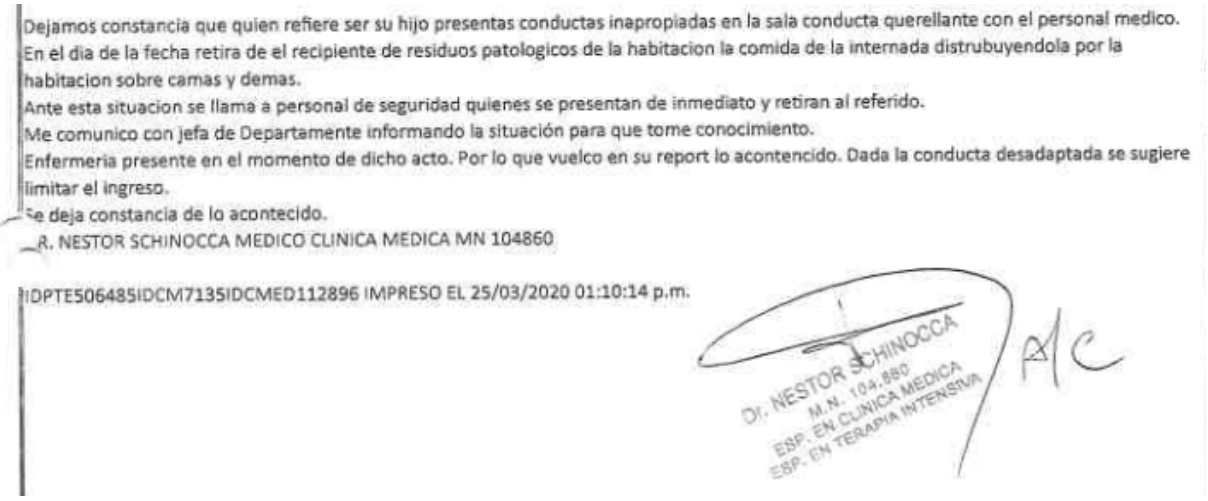

Dejamos constancia que quien refiere ser su hijo presentas conductas inapropiadas en la sala conducta querellante con el personal medico.
En el dia de la fecha retira de el recipiente de residuos patologicos de la habitacion la comida de la internada distrubuyendola por la habitacion sobre camas y demas.
Ante esta situacion se llama a personal de seguridad quienes se presentan de inmediato y retiran al referido.
Me comunico con jefa de Departamente informando la situación para que tome conocimiento.
Enfermeria presente en el momento de dicho acto. Por lo que vuelco en su report lo acontencido. Dada la conducta desadaptada se sugiere limitar el ingreso.
Se deja constancia de lo acontecido.
DR. NESTOR SCHINOCCA MEDICO CLINICA MEDICA MN 104860
IDPTE506485IDCM7135IDCMED112896 IMPRESO EL 25/03/2020 01:10:14 p.m.
DR. NESTOR SCHINOCCA
M.N. 104.880
ESP. EN CLINICA MEDICA
ESP. EN TERAPIA INTENSIVA

Figura 1: Versión del médico. Página 123 de HistoriaClinica.pdf

Ese fue el último dia que vi a mi madre. Ni reconocí el cuerpo.

A la noche voy al Hospital, no me dejan ingresar, llamo al 911 con la idea de que podrían averiguar al menos quien dió la orden de no dejarme ingresar. Tenía la idea de que Policía podría redactar un acta donde quede constancia de que no me dejan ingresar a un Hospital Público. Me recomiendan dejar una nota al Director.

3.1.9. 26 de marzo de 2020

Hago una nota de 3 páginas que dejo en la Dirección del Hospital. Esa nota desapareció y nunca tuve respuesta. Las copias las tengo firmadas por la que supongo es la secretaria, ver **Prueba** 4.3.5.

3.1.10. 28 de abril de 2020

En teoría mi madre es encontrada sin vida a las 0:30. ¿Tenian que darle medicación a esa hora o cómo se dieron cuenta que no dormía plácidamente?

En teoría me llamaron antes de la 1. Yo no atendí. No volvieron a intentar comuni-

carse durante el resto del dia.

3.1.11. 29 de abril de 2020

Treinta y tres horas después del primer llamado, vuelven a llamar cerca de las 10. Me avisan de que vaya urgente. Me costó subir las escaleras. Otro doctor me dió la noticia, Monteverde o algo así era el nombre.

Y teniendo familiar, quien reconoce el cadáver es el Director, según figura en el acta de defunción en la *Página 17 del Archivo* ***MPF462972.pdf***. Segun el acta, la causa de muerte es **Insuficiencia Respiratoria Aguda**.

3.1.12. 30 de abril de 2020

Supongo que el 30, porque recuerdo que fue uno o dos días después[2] de la noticia que fui a Admisión y Egresos a pedir por la Historia Clínica y me dijeron que no la tenian. Fui entonces a la Unidad 1, donde hasta llegar al fondo, donde estaba enfermería, vi que no había ningun paciente en ninguna habitación pero si estaban limpiando o desinfectando.

Me pregunto ¿estaban esperando a que mi madre muriese para desinfectar, siendo la única paciente en toda la sala o efectivamente la movieron a una sala de COVID como dice Schinocca en la denuncia que me hizo?

> "y luego en Sala Covid 19, donde finalmente falleció."
>
> "la madre de Kosciuk pasó a una sala adaptada para pacientes con virus COVID-19"
>
> *Página 2 del* Archivo **MPF497727.pdf**

Es extraña la denuncia del médico porque no hay ni una fecha correcta, y es una denuncia hecha con abogado y firmada también por el Director, con lo que es de esperar que hubiesen podido revisar

[2] el 1ro sería feriado y no habria nadie y después ya es fin de semana

También el 29 a las 14:24, la persona del Centro Coordinador de PAMI escribe:

> "no pude comunicarme aún con el médico/a tratante que estuvo hoy porque hubo modificiaciones en la sala y el personal"
>
> *Página 4 del Archivo* ***mails-con-pami.pdf***

Y aunque se demostrase que mi madre contrajo COVID, mi denuncia seguiría siendo la misma.

3.2. Historia Clínica Faltante

La Historia Clínica se puede dividir en dos partes: la primera parte en la Unidad 4 de Clínica Médica que va desde el 23 de enero al 12 de marzo, y la segunda estancia en la Unidad 1 de Clínica Médica desde el 12 de marzo al 28 de abril, siempre de 2020.

Según la constancia del acta de presentación de fecha 18 de mayo de 2020, se incautó el original con un total de 225 fojas. Ver *Página 38 del Archivo* ***MPF462972.pdf***.

También el 3 de junio de 2020, se menciona que fueron escaneadas esas 225 fojas y subidas al sistema KIWI. Ver *Página 42 del Archivo* ***MPF462972.pdf***. Es curioso que la fecha de escaneo de la Historia Clínica según fecha de creación del PDF es el 26 de mayo de 2020.

La Historia Clínica fue digitalizada antes de que entierren a mi madre, pero fue subida al sistema despues del entierro. ¿En qué momento iban a revisar la integridad de la Historia Clínica?

3.2.1. Partes faltantes

El faltante de páginas que no debió pasar inadvertido para una persona supuestamente calificada para analizar estos temas.

Es sorprendente como la perito forense pudo leer las cosas de enfermería cuando falta casi la mitad, 46 días de los 99 de internación:

> "Según lectura de la copia de historia clínica, la paciente fue evaluada diariamente, con evoluciones y **asistencia de enfermería, desde la higiene personal a la asistencia en la ingesta diaria de las comidas**"
>
> *Página 64 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Volviendo a las partes faltantes, si uno revisa la Historia Clínica, puede comprobar en relación a la Unidad 4, Cama 4 la existencia de:

Indicaciones de enfermería Desde el 22 de enero de 2020 (foja 198) hasta el 6 de marzo de 2020 (foja 170).

Hojas de Enfermería desde el 22 de enero de 2020 (foja 219, reverso) hasta el 12 de marzo de 2020 (foja 205)

Balances y Controles desde el 22 de enero de 2020 (foja 220) hasta el 12 de marzo de 2020 (foja 224).

En la Unidad 4 hay un faltante en las *Indicaciones a Enfermería* de los días 7, 23, 24 y 25 de febrero, y pegado al traslado a la Unidad 1, faltan los ultimos días en la Unidad 4, esto serían el 9, 10, 11 y 12 de marzo de 2020.

Se hace notar que **no hay foja 225**.

De la simple observación de la existencia de tres registros de enfermería, a saber: *Indicaciones a Enfermería*, *Hojas de Enfermería* y *Balances y Controles*, todos de la Unidad 4 (y Guardia), resulta evidente, por complementariedad, la ausencia total de esos mismos registros en la Unidad 1.

RESUMEN

Faltan:

Indicaciones a Enfermería de la **Unidad 4**, los días 7, 23, 24 y 25 de febrero de 2020 y desde el 9 de marzo de 2020 hasta el 12 de marzo de 2020; y de la **Unidad 1** desde el 12 de marzo de 2020 hasta el 28 de abril de 2020.

Hojas de Enfermería de la **Unidad 1** desde el 12 de marzo de 2020 hasta el 28 de abril de 2020.

Balances y Controles de la **Unidad 1** desde el 12 de marzo de 2020 hasta el 28 de abril de 2020.

3.2.2. Parte médica

Quizá sea lo normal, pero no hay historia clínica de días sábados, domingos ni feriados.

Respecto a la parte médica, llama un poco el desorden que arranca en abril a foja 84, empieza bien, por el 1ero, siguen 2, 6, 14, 20, 3 fojas con laboratorios y siguen los días 3, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27 y 28. ¿No hay nada que garantice la correlatividad? Es verdad que cada página tiene fecha y hora, pero ¿cualquier hoja puede ser agregada en cualquier lugar?

Como detalle importante se hace notar que la última intervención del Dr. Schinocca fue el 13 de abril y que en ningún momento la Dra. Martiarena intentó ponerse en contacto conmigo para que vaya a cuidar de mi madre.

3.2.3. Fojas digitalizadas faltantes

En el documento PDF aportado por el CIJ, deberían existir 225 fojas, tal cual fuera incautado y numerado.

En el PDF no se pudieron encontrar las fojas 24, 25 y 26. La 38, 39 y 40. La 115. La 135. La 152. La 168 y 169. La 199 y finalmente la 225. ¿Existen en el original o también son una forma de elevar la numeración artificialmente? ¿La perito forense no tiene que prestar atención a estos "detalles"?

Las fojas 18 y 19 son la misma. *Página 35 del archivo* ***HistoriaClinica.pdf***.

3.3. Historia Clínica Adulterada

3.3.1. Comentarios de un no experto

Llama la atención que algunas cosas esten en orden cronológico, el informe medico por ejemplo, hasta que lo desacomodan en abril, mientras que otras cosas, por ejemplo, el laboratorio tengan lo nuevo adelante.

3.3.2. Expulsión de fantasía

Transcribo a continuación las injurias volcadas por el médico en la Historia Clínica con fecha 26 de marzo de 2020, tal como se ve en la Figura 2:

> Dejamos constancia que quien refiere ser su hijo presenta conductas inapropiadas en la sala (sic) conducta querellante con el personal médico.
>
> En el día de la fecha retira de el (sic) recipiente de residuos patológicos de la habitación la comida de la internada distribuyéndola por la habitación sobre camas y demás.
>
> Ante esta situación se llama a personal de seguridad quienes se presentan de inmediato y retiran al referido.
>
> [...]
>
> Enfermería presente en el momento de dicho acto por lo vuelco en su *report* lo acontecido. Dada la conducta desadaptada se siguiere limitar el ingreso.

Lamentablemente no es necesario que los médicos presenten pruebas de nada de lo que escriben. Teniendo todos celulares bien podrían haber captado esos eventos con filmaciones durante las supuestas acciones violentas o con fotos del desastre realizado con posterioridad. Es también una lastima que no haya llamado a la policía como amenazó.

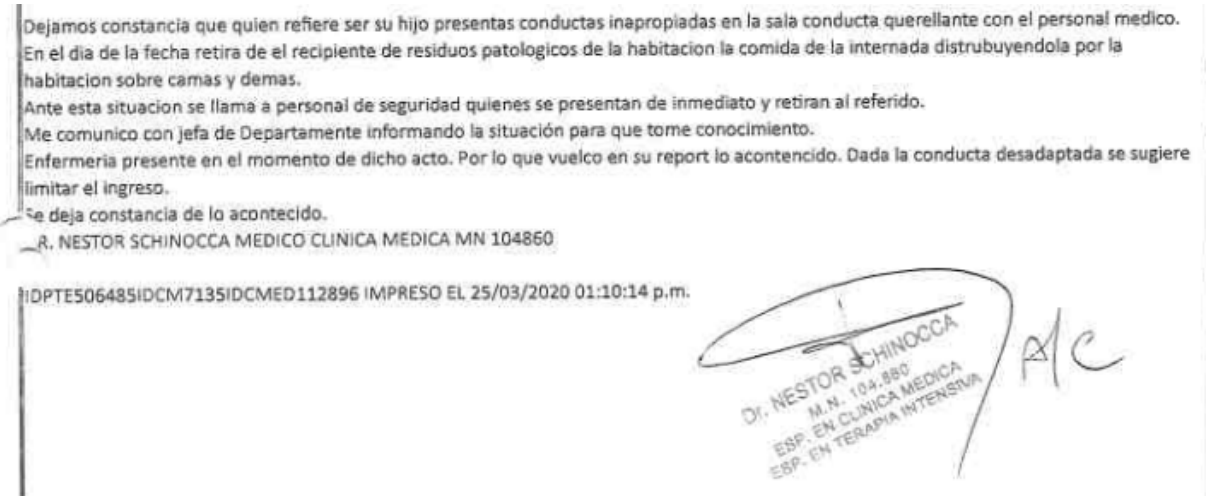

Dejamos constancia que quien refiere ser su hijo presentas conductas inapropiadas en la sala conducta querellante con el personal medico.
En el dia de la fecha retira de el recipiente de residuos patologicos de la habitacion la comida de la internada distrubuyendola por la habitacion sobre camas y demas.
Ante esta situacion se llama a personal de seguridad quienes se presentan de inmediato y retiran al referido.
Me comunico con jefa de Departamente informando la situación para que tome conocimiento.
Enfermeria presente en el momento de dicho acto. Por lo que vuelco en su report lo acontencido. Dada la conducta desadaptada se sugiere limitar el ingreso.
Se deja constancia de lo acontecido.
DR. NESTOR SCHINOCCA MEDICO CLINICA MEDICA MN 104860
IDPTE506485IDCM7135IDCMED112896 IMPRESO EL 25/03/2020 01:10:14 p.m.
DR. NESTOR SCHINOCCA
M.N. 104.880
ESP. EN CLINICA MEDICA
ESP. EN TERAPIA INTENSIVA

Figura 2: Versión del médico. Página 123 de HistoriaClinica.pdf

3.3.3. Expulsión en video

Lo que pasó y por suerte tengo filmado se puede ver en la **Prueba 4.1.8**, con lo que el relato que usa para expulsarme y poder dejar abandonada a mi madre es completamente mentira.

Comentarios:

- Todo está limpio,
- la comida sigue en las bandejas,
- el tacho de basura sigue en el baño,
- el médico ingresa con el de seguridad ¿el mismo médico fue a buscarlo?
- desde las 11 hasta las 12:30 estuve esperando con las bandejitas sobre la mesa,
- como bien dice el médico, la comida estaba en la basura y como se ve en los videos, intacta, no alimentaron a mi madre, ni lo intentaron,
- mi madre estaba sola, no había ninguna mujer de apellido Lizardocomo diría luego a pedido del Fiscal Rozas.

- no se ve a nadie de enfermería, aunque la Jefa de Enfermería me aviso antes de que “tire eso” y yo no podía tirar evidencia. Ese es el motivo del video **Prueba 4.1.7**.
- **IMPORTANTE**: se ve el aparato para aspirar flema, ahora para alimentar a mi madre harían falta 2 personas. Recién el 20 de abril dicen ponerle sonda ¿cuantos días estuvo sin comer?
- el cartel rojo indica que tenía que estar aislada, pero desde el cambio de unidad del día 12 hasta el 18 estuvo compartiendo la habitación. ¿Aislamiento? Bien, gracias.

3.3.4. Nota del libro de quejas

En foja 20 se puede apreciar mi nota en el libro de quejas y en fojas 21 y 22 dos veces la respuesta del médico, la primera con fecha 28 de febrero y la segunda el 4 de marzo.

- Agregaron estas fojas a partir de la Orden de Presentación del 15 de mayo. ¿Cuando se agregó?
- Como no hay orden, no se sabe cuándo agregaron estas páginas.
- ¿Es normal que agreguen notas del libro de quejas en la Historia Clínica?
- Si agregaron la nota del libro de quejas, no debieron adjuntar tambien mi nota al Director con fecha 26 de marzo de 2020, ver **Prueba 4.3.5**.
- O simplemente lo agregaron como relleno
- Si me lo solicitan puedo presentar mis comentarios a esa nota

3.3.5. Medicaciones

Sin la *Hoja de Enfermería* no sabemos que medicamentos le proporcionaban o si le daban medicamento alguno.

Por ejemplo, es sospechosa la elevación del RIN según los laboratorios de hematología, en orden cronológico:

- 27/12/19, foja 159, reverso, p. 298, Valor RIN: 3,90
- 19/1/20, foja 157, reverso, p. 294, Valor RIN: muestra hemolizada
- 20/1, foja 156, p. 291, Valor RIN: 7,96, piden nueva muestra
- 21/1, foja 154, p. 287, Valor RIN: muestra mal enrasada (sic) supongo
- 22/1, foja 151, p. 283, Valor RIN: 1,51
- 23/1, foja 145, p. 271, Valor RIN: 1,15
- 24/1, foja 144, p. 269, Valor RIN: no figura
- 27/1, foja 142, p. 265, Valor RIN: 1,24
- 31/1, foja 139, p. 259, Valor RIN: 1,26
- 10/2, foja 135, p. 253, Valor RIN: 1,14
- 17/2, foja 132, p. 247, Valor RIN: 1,17
- 27/2, foja 130, p. 243, Valor RIN: 1,01
- 2/3, foja 127, p. 237, Valor RIN: no figura
- 13/3, foja 124, p. 231, Valor RIN: 1,22
- 21/3, foja 123, p. 230 reverso, Valor RIN: 2,07
- 27/3, foja 117, p. 217, Valor RIN: 2,93
- 30/3, foja 89, p. 163, Valor RIN: 2,41
- 20/4, foja 110, p. 205, Valor RIN: no figura
- 20/4, foja 113, p. 211, Valor RIN: 3,08
- 21/4. foja 107, p. 199, Valor RIN: no figura

3.3.6. Laboratorios

Realizando la búsqueda de los laboratorios de hematología desconozco si la frecuencia de los controles es la correcta. Pero supongo que si.

3.3.7. 25 de marzo de 2020

Es mentira que se haya explicado al familiar nada el día 25 puesto que ningun médico vino a ver por qué tiraban la comida a la basura en lugar de alimentar a la paciente hasta las 12:35 cuando aparece el Dr. Schinocca y me expulsa.

3.3.8. Fechas posteriores al 25 de marzo

Comentarios difamatorios empezando por el 26 de marzo son de relleno. No volvi a entrar a esa sala hasta principios de mayo.

3.3.9. 31 de marzo de 2020

El Dr. Schinocca menciona que fui al hospital llamado por servicio social, supongo que quiso decir PAMI. Interesante como PAMI intenta comunicarse conmigo y tiene éxito, sin embargo los supuestos llamados por parte de Clinica Médica, no. ¿No pensaron los médicos en pedirle a PAMI que me cite a pedido de ellos? Supongo que la posibilidad la vieron, pero la omitieron.

3.4. Abandono de persona. Denuncia MPF 462972

3.4.1. 5 de mayo de 2020

Ingresa la denuncia y queda registrada como **DENUNCIA N° 632469**. Imagen **??**. Archivo **MPF462972_Extra.pdf**, Página 1.

No se de plazos procesales, pero no me parece un plazo razonable para cosas que requiren "allanamientos".

3.4.2. 12 de mayo de 2020

> En este sentido, deberá entrevistarse con el denunciante a fin de que éste brinde una declaración pormenorizada de como se dieron los hechos y aporte toda la documentación y estudios que posea respecto de la causante.
>
> [...]
>
> Asimismo, el personal del CIJ deberá hacerse presente en el Hospital de Agudos Piñero a los fines de obtener con una orden de presentación, la correspondiente historia clinica digitalizada [...]
>
> *Pagina 31 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

No se sabe si la orden de presentación era para llevarse un original o copia, ni se a que se refiere con "digitalizada".

Este proveido sería anulado para pedir el allanamiento:

> Habiendo el suscripto efectuado un nuevo anàlisis dejese sin efecto la orden de presentación ordenada y pasen el presente caso a estudio para dictaminar.
>
> *Página 32 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Ya en la solicitud de allanamiento pone el Fiscal:

> Por otro lado, entiendo que es prioritario la obtención del original completo de la historia clínica y no una copia certificada. Tal argumento lo baso para el caso que resultase necesario efectuar un reconocimiento de firmas y potencialmente alguna pericia caligráfica para el caso que alguna rúbrica fuera no reconocida. [...]
>
> *Página 27 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

¿Quién se supone que iba a poner en duda las firmas, si nadie siquiera iba a revisar si la Historia Clínica estaba completa? Es más, las partes que faltan son las que más firmas tenían.

> En conclusión, entiendo que la orden de allanamiento es el medio idóneo para obtener el original de la historia clínica, elemento de prueba que resulta sustancial para poder identificar a los autores y determinar responsabilidades, o bien descartarlas.
>
> *Página 28 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

¿Qué tal enviar a una persona a que secuestre inmediatamente el original como pasa en otras denuncias que vi?

> [...] se vería frustrada la posibilidad de identificar a los autores del delito y su grado de participación, así como también el mecanismo de producción. En definitiva, se vería imposibilitada la determinación de cómo se dieron los hechos investigados que llevaron al fallecimiento de la Sra. Kuchasky y de esta manera, determinar la verdad de los hechos.
>
> *Página 28 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

En vista de lo acontecido no puede parecerme más que relleno.

3.4.3. 13 de mayo de 2020

El Juzgado 21, Secretaria 41 rechaza el allanamiento, ver Cédula electrónica en *Página 33 del Archivo* ***MPF462972.pdf***. Aunque la Jueza copia bastante de mi testimonio, no menciona nunca lo de la expulsión y relata cosas del 26 de marzo que nunca sucedieron porque apenas pude llegar hasta la Dirección a dejar una nota, ver Sección 3.1.9.

Dice la Jueza:

> Conforme lo expuesto, tanto el propio denunciante como así también el Sr. Fiscal a cargo del caso se encuentran habilitados por ley para solicitar la documentación cuya incautación se solicita mediante el pedido de allanamiento incoado.
>
> *Página 34 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Pareciera que la Jueza nos iguala al Fiscal y a mi, podría interpretarse como que los dos podemos hacer lo mismo: los dos pueden pedir una copia. Desconozco si un Fiscal puede incautar el original sin orden judicial[3].

Agrega tambien que:

> Conforme lo expuesto, tanto el propio denunciante como así también el Sr. Fiscal a cargo del caso se encuentran habilitados por ley para solicitar la documentación cuya incautación se solicita mediante el pedido de allanamiento incoado.
>
> *Página 34 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

¿Significa eso que ambos podemos solicitar el original o que ninguno de los dos puede hacerlo? El Fiscal se llevó el original.

3.4.4. 15 de mayo de 2020

De nuevo con las pruebas y las entrevistas:

> deberá entrevistarse con el denunciante a fin de que éste brinde una declaración pormenorizada de como se dieron los hechos y aporte toda la documentación y estudios que posea respecto de la causante.
>
> *Página 35 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Nuevamente, nunca sucedió esto. ¿El CIJ no acataba este proveído porque no queria o porque le decian que no lo haga?

[3] Es decir, firmada por un/a juez/a

Y la orden de presentación que no aclara si quiere el original o la copia:

> [...] librar una ORDEN DE PRESENTACIÓN a fin de que el personal del CIJ se haga presente en el Hospital de Agudos Piñero a los fines de obtener la correspondiente historia clinica [...] junto con los estudios realizados.
>
> *Página 35 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Ahora si, en la Orden de Presentación, finalmente el Fiscal aclara que quiere el original:

> "[...] mediante la presente orden de presentación, obtenga el original de la historia clínica de la paciente [...]"
>
> *Página 36 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

El mismo 15 entregan la nota.

3.4.5. 18 de mayo de 2020

Van a retirar la Historia Clínica, luego de 2 horas (porque 3 días no fueron suficientes para prepararla) pueden retirar **sólo** 225 fojas[4], en la *Página 38 del Archivo* ***MPF462972.pdf*** se puede ver el Acta de Orden de Presentación.

Me llama la atención que pongan "Siendo las XX" dos veces. Solo hay foto del acta, y la foto es del 3 de junio de 2020. ¿Hay alguna garantía de que esas firmas se hayan realizado el 18 de mayo?

3.4.6. 27 de mayo de 2020

Después de un mes en la morgue del Hospital, a la espera (yo esperaba) de que el Fiscal hiciera la autopsia o al menos pesara la bolsa, llevan el cuerpo de mi madre

[4] ¿Son 225 fojas pocas para una persona que estuvo internada casi 100 días? ¿Hubiese llamado la atención a alguien con experiencia en el tema?

rumbo a Chacarita.

3.4.7. 3 de junio de 2020

Pese a la intención de allanar en busca de la verdad, recién hoy suben la Historia Clínica digitalizada al sistema KIWI y aún nadie revisó si esta completa o no.

Tengo la idea, ingenua, de que estando el cuerpo en la morgue del Hospital, y decidiendo el Fiscal no hacer autopsia, sería al menos prudente, primero verificar la integridad de la Historia Clinica antes de permitir que se entierre.

En el Acta de Orden de Presentación el precinto tenia el número 3846 (*Página 38 del Archivo* ***MPF462972.pdf***), ahora, luego de la digitalización el número es el 3825, parece ser que los usan en orden descendente.

3.4.8. 8 de junio de 2020

Un intento por ser querellante, ver *Página 45 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

* * *

En la *Página 90 del Archivo* ***MPF462972.pdf*** aparece un mail mio a la Fiscalia con hora 17:31, en la que le comento que estoy escribiendo mi version de los hechos en mi pagina web, y les paso la dirección exacta:

https://kosciuk.com.ar/muerte-en-el-hospital-pinero/

Este dato sería filtrado al médico o la declaración del médico sería editada por el MPF luego.

* * *

En un proveido el Fiscal encarga al Gabinete Médico del CIJ algunas preguntas, ver *Pagina 46 del Archivo* ***MPF462972.pdf***, los comentarios al informe de la perito estan en la Seccion 3.6.

En ese proveido tambien pone el Fiscal:

> Por otro lado, désele intervención al Cuerpo de Investigaciones Judiciales a fin de que personal de dicha dependencia proceda en forma urgente a realizar tareas de investigación tendientes a determinar donde se encuentra actualmente el cuerpo [...]
>
> *Página 47 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

La investigación sobre el cuerpo fue la excusa para que el CIJ vaya al Hospital a conseguir el falso testimonio de 3 médicos: el que me expulsó, la jefa de éste, y otro más.

Si quería averiguar sobre el cuerpo podría haberlo hecho el 15 o el 18 de mayo cuando el CIJ fue al Hospital por la Historia Clínica.

3.4.9. 10 de junio de 2020

A las 10:02 la perito forense envia su informe. Ver *Página 67 del Archivo* ***MPF462972.pdf***.

* * *

El mail de Diletto

A las 10:48 Graciela Diletto, no se quien es, pero supongo que es será la Jefa de la perito forense, vuelve a enviar de nuevo el mismo informe junto con algunos comentarios que a mi me parecen hechos a pedido del propio Fiscal.

> No me parece necesario realizar una inhumaciñon [...] Justamente resulta lógico no realizar manipulación de un cadáver que se encuentra en estado de putrefacción.

Pagina 53 del Archivo ***MPF462972.pdf***

Aunque el email no es una respuesta, tiene la respuesta a la pregunta ¿conviene hacer una inhumación? No se sabe a quien se le ocurrió la idea de inhumar. Al igual que la negativa del allanamiento es para que parezca que el Fiscal queria allanar, esta respuesta es para aparentar que el Fiscal quería inhumar.

Escapa a mi conocimiento si el comentario sobre estado de putrefacción, necesita del conocimiento de la fecha de entierro o es independiente. También creo que si querían hacer autopsia se les ocurrió un poco tarde.

> "dado que de la historia clínica y del informe se desprende la causa de muerte que no guarda relaciòn directa con la pandemia Covid 19]"
>
> *Pagina 53 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

¿De la Historia Clínica? Entonces Diletto también leyó la Historia Clinica y no encontró que faltan partes? Y la causa de defunción, Insuficiencia Respiratoria Aguda ¿no le llama la atención a ninguna de las dos?

Sigue Diletto:

> "De la lectura del informe surge a las claras que la sra. kUCHASKI ha recibido asistencia médica en todo momento."
>
> *Pagina 53 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

De la lectura del Informe puede ser, pero no de la Historia Clínica. Sigo sin saber como era alimentada desde que me expulsaron hasta que dicen ponerle sonda.

Y termina con

> "podría efectuarse una evaluación psiquiatrica para ver cual es el estado de salud mental del hijo."
>
> *Pagina 53 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Este correo de Diletto parece un favor pedido por el Fiscal, "necesito que me digas tres cosas: 1) que no hay que hacer autopsia, 2) que la Historia Clínicano tiene irregularidades, y 3) pedí una pericia siquiatrica para el hijo".

Como ya se mencionó, en la *Página 67 del Archivo* ***MPF462972.pdf*** puede comprobarse que la propia Peretti envió el informe a la Fiscalia a las 10:02 y Diletto lo envía de nuevo 46 minutos más tarde[5].

3.4.10. 11 de junio de 2020

El proveído simple indica que los escritos presentados por el abogado para ser querellante, son ilegibles.

* * *

Denuncié telefónicamente por encubrimiento al Fiscal por estar evitando la autopsia que era la única prueba creíble, a menos que la autopsia la haga CABA.

Luego a la tarde denuncie por separado a cada organismo: Hospital, Defensoría, Policía, PAMI y al MPF (porque no hicieron nada cuando denuncie que no me dejaban ingresar al Hospital, ver Archivo **mails-con-mpf-pre-fallecimiento.pdf**.

La denuncia contra PAMI esta en la Seccion 3.8.

3.4.11. 18 de junio de 2020

El proveido (con fecha 18 de mayo) agrega las nuevas denuncias. Ver *Página 108 del Archivo* ***MPF462972.pdf***.

* * *

[5] *Pagina 53 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Otro proveido, también con fecha 18 de mayo, da intervención al Juzgado sobre el rechazo a la querella. Ver *Página 111 del Archivo* ***MPF462972.pdf***.

* * *

Otro proveido, donde **gracias a la sugerencia de Diletto** se me pide una **evaluación psiquiátrica y psíquica** para permitirme ser querellante. Ver *Página 112 del Archivo* ***MPF462972.pdf***.

Nunca se contactaron del Gabinete Médico, quizá porque no tenían intención, y luego el Fiscal usaría como excusa que no se realizó la pericia.

3.4.12. 22 de junio de 2020

La Jueza da su opinion sobre el tema de la querella, la cual excede mi capacidad. Sin embargo hay un párrafo que me parece interesante:

> Paralelamente, ninguna consideración en concreto ha efectuado el Sr. Fiscal en torno a la legitimación del Sr. Kosciuk para ser aceptado en al calidad procesal invocada. De hecho, va de suyo que no ha tenido posibilidad de valorar dicha circunstancia precisamente en virtud de la incompleta presentación del pretenso querellante.[6]

Según interpreto, diría algo como: "usted lo quiere rechazar por loco, pero ni siquiera sabe si es el hijo".

3.4.13. 23 de junio de 2020

Nuevo escrito del Fiscal, ahora si esta bien la parte formal, pero como no se hizo la pericia (y supongo que no habia apuro en hacerla) decide rechazar de nuevo[7]

[6] *Página 114 del Archivo* ***MPF462972.pdf***
[7] *Página 123 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Es curioso como el Fiscal se preocupa por evitarme problemas en caso de aceptarme, pero apenas me acepto como querellante, lo termino archivando a los pocos días.

* * *

En otro proveido, en donde solicito información sobre el caso, me responden que:

> corresponde hacerle saber que hasta tanto no se resuelva la nueva petición de ser tenido como querellante, por parte del Juzgado PCyF Nro. 21, es que no se le podrá remitir las constancias del caso. [8]

¿El acceso a la Historia Clínica está incluido dentro de las constancias del caso? ¿Si nunca me aceptaban como querellante, nunca hubiese tenido acceso a la Historia Clínica?

¿Como podría obtener copia como heredero forzoso, tal cual dijo la Jueza, si el Fiscal se llevó el original?

3.4.14. 24 de junio de 2020

Escrito del Juzgado 21, la jueza parece reprochar de que el Fiscal sigue sin determinar la legitimidad o no[9].

3.4.15. 26 de junio de 2020

De nuevo escribe el Fiscal, y aca usa como excusa la sugerencia hecha con la única y misteriosa aparición de Diletto el 10 de junio, ver Sección. Habla de "otorgar roles de suma importancia" y ya empieza a filosofar sobre un tema que imagino que

[8] *Página 127 del Archivo* ***MPF462972.pdf***
[9] *Página 130 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

se ha repetido miles de veces: intentar declarar insano al querellante para entorpecer/impedir la investigación. Y todo gracias a las declaraciones del medico y su jefa. Vuelvo a recordar la intención del médico de hacerme pasar por insano.

> si el Fiscal rechace la petición de quien pretenda ser querellante, es ahora la Jueza quien debe resolver la cuestión y fijar posición.
>
> [...]
>
> que entiendo que debe ser Vs quien tome la decisión de tener o no tener por parte querellante al Sr. Kosciuk
>
> *Página 144 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Parece decir el Fiscal: "bueno, decida usted y yo hago caso". Pero no sería así.

3.4.16. 29 de junio de 2020

El Juzgado 21 dice:

> Por el contrario, rechazó su petición fundamentando la necesidad de determinar, primero, su capacidad civil, para lo cual ordenó un examen psiquiátrico respecto del nombrado.
>
> [...]
>
> lo cierto es que esa circunstancia no puede invocarse como causal para rechazar la petición de ser tenido como parte querellante.[10] [...] en todo caso deberá dársele intervención a la justicia civil para la sustanciación del proceso sobre la determinación de la capacidad correspondiente [...][11]

¿Todo este lío para impedir que se pida una autopsia? Por morir en casa se nos regala una autopsia. ¿Será que el Fiscal buscaba evitar la autopsia por algo?

[10] *Página 189 del Archivo* ***MPF462972.pdf***
[11] *Página 190 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

* * *

Trabajando en horario extendido, el Fiscal "interpone recurso de reposición con apelación en subsidio":

> Es decir, el motivo por el cual la fiscalìa denegó la pretensiòn de ser querellante es que en virtud de las distintas menciones recogidas tanto por los médicos como por el investigador Omar Moure, del cuerpo de Investigadores judiciales del MPF, se han reflejado comportamientos y conductas llevadas a cabo por Nicolás Kosciuk que hicieron que la mèdica Dra. Graciela Diletto aconsejara llevar a cabo una evaluaciòn médica respecto del nombrado. Y así fue como se ordenó a la fecha, **no lográndose por el momento materializarse tal informe**.[12]

Mentiras dichas por los médicos en la Historia Clínica, luego vueltas a repetir por los mismos médicos en una "investigación".

Algo que no figura en el expediente, es el mail titulado "Fiscalía PCyF Nro. 20 - Notifica en lo relativo al pedido de querella - CASO MPF 462972 [...]" **ni mi respuesta** que se adjunta como *Página 2 del Archivo* ***MPF462972_Extra.pdf*** , en la que me viendo el ping-pong de la legitimidad decido ofrecerme voluntariamente para la pericia siquiatrica dada mi desesperación por conseguir la autopsia.

En ningún momento el Gabinete Medico intento contactarse con anterioridad, solo era una excusa para decir que "la pericia aun no se pudo realizar".

> esta Fiscalía ha ordenado la realización de una batería de pruebas en el caso, entre ellas una evaluación psiquiátrica sobre el pretenso querellante -a sugerencia del Gabinete Médico del CIJ-, la que se encuentra pendiente de realización.[13]

¿Bateria significa uno o dos? Nótese el "a sugerencia de" y "pendiente".

[12] *Página 152 del Archivo* ***MPF462972.pdf***
[13] *Página 122 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

3.4.17. 30 de junio de 2020

Un informe del investigador donde supongo que archivaron sin investigar:

> La primera denuncia formal de un hecho se dio el día 30 de marzo de 2020 (DEN 622729) donde denunció un hecho de obstaculizar el ingreso y/o la salida de un lugar público (art. 57 CC) la cual tramitó en la UIT OESTE junto con otra denuncia similar del día 2 de abril de 2020 (DEN 623861), siendo que ambas fueron archivadas por el Sr. Fiscal Coordinador Oeste en los términos del art. 41 de la LPC
>
> *Página 193 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Jamás me enviaron resoluciones de esas 2 denuncias, mucho menos se contactaron para nada. Para el 30 de marzo ya existían mis llamados al 911, y debería estar registrado por la enorme cantidad de policias que concurrió el 25 de marzo a la noche de que tenía prohibido el ingreso.

* * *

El mismo día en que me ofrezco para las pericias me entrevistan por Whatsapp, en cambio al Fiscal no le hacían caso.

La pericia siquiatrica / sicológica aparece en *Página 196 del Archivo* ***MPF462972.pdf***. Aparece como documentación aportada por la Fiscalía:

> 2. Historia Clínica aportada por el Hospital Piñero.[14]

A mi no convence ese informe, muchas de las cosas que dije estan mezcladas, no se si a proposito, cosas de distintos meses y unidades están mezcladas en la misma oración.

El diagnostico es transtornado paranoide, aunque la única persona a la que habia denunciado con nombre y apellido era el propio Fiscal.

[14] *Página 196 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

3.4.18. 3 de julio de 2020

Suben los 2 informes, el diagnostico parece calcado en ambos informes.

A mi no me gusta el diagnóstico de desconfiar de los demás cuando justamente tengo 2 juicios por pagarés que no me devolvieron la plata a personas que no son amigos directos. Es decir, para ser una persona desconfiada, doy lástima.

Por ejemplo, todo esto, así escrito, es mentira:

> Tras su ingreso a la Guardia, refiere que su madre es asistida mejorando su cuadro clínico, él decidió retirarse a su domicilio. Requerida su presencia en el hospital, al día siguiente, para efectivizar el alta médica, el mismo se negó a la misma manifestando: "acá está mejor que en su casa".
>
> *Página 200 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Ya dije que me retire ante el intento del médico de darle un alta que simplemente era sacarsela de encima. Los llamados para que la retire fueron esa misma noche. Que esté mejor en el Hospital que en casa, fue precisamente el motivo por el que me retiré y no al día siguiente.

No se si vale la pena criticar el resto del informe porque son 12 páginas y debería comentar cada oración supuestamente dicha por mi.

3.4.19. 13 de julio de 2020

Pese a los informes que para mi son cualquier cosa menos algo serio, al Fiscal no le importa y decide aceptarme como querellante. Nos envian un enlace de WeTransfer para descargar el expediente digitalizado.

Eso si, se tomó su buen tiempo para leer tan poco texto. Y para mi es importante señalarlo porque decidió archivar la causa el 27, 14 días despues de aceptar la querella.

¿Son 14 días plazo suficiente para que la querella pueda leer todo el expediente?. Creo que no. ¿Cuanto tiempo estuvo el Fiscal rechazando la querella? Desde el

9 de junio hasta el 13 de julio. Más de un mes.

3.4.20. 27 de julio de 2020

El abogado pide copia (un nuevo enlace), le dicen que ya lo enviaron una vez, pero dos veces no. El abogado, curiosamente, agradece la negativa.

3.4.21. 30 de julio de 2020

A las 12:19 hay otro correo del abogado pidiendo copias.

Y cuatro horas despues, el Fiscal, sabiendo que el abogado no tenia copias, decide archivar. La resolución del Fiscal merece capitulo a parte. Ver Sección 3.7.

> k) A ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, y aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo solicite expresamente;

No se si eso va contra la Ley de Victimas o algún código procesal. El Fiscal sabiendo que el querellante no habia querellado, que el abogado no tenia copias y las pedia para poder querellante, de todas formas decide archivar. Y se le olvidó el proveído donde decia que aporte pruebas y testimonio.

3.5. El informe del investigador. MPF462972

El informe del investigador arranca con la excusa de ir **personalmente** al Hospital a averiguar que fue del cuerpo de mi madre. Pero la intención era otra:

> "quien interiorizado del proceso de la presente diligencia solicitó ampliar la misma, solicitando que se entreviste a distintos profesionales que du-

> rante la internación de la Sra. Margarita Leonor Kuchasky hayan presenciado la conducta del hijo de esta"
>
> *Página 73, 74 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

¿Interiorizado de que? El informe de la perito forense es del 10 de junio, al igual que las sugerencias siquiatricas de Diletto. Este informe es del 9 de junio, por lo que no me cierran las fechas para que el Fiscal decida investigar las conductas del hijo. **¿Es que el Fiscal ya había coordinado con los medicos armar estas declaraciones?**.

3.5.1. Dra. Gaset

Gaset era la jefa del médico que me expulsó.

> la actitud del hijo de la internada fue siempre agresiva y demandante, lo cual era reclamado a ella por el personal médico.
>
> *Página 74 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Como dice en la Historia Clínica yo no iba al parte médico porque no me interesaba hablar con los médicos. Mi madre antes de ser internada tomaba muchos mas remedios de los que le suministraban en el Hospital. Excepcionalmente iba temprano cuando tenía que hablar con los médicos, como cuando fui especialmente a pedir la Historia Clínica para poder mostrarle a la médica de cabecera que estaban ignorando casi todas las enfermedades y tratamientos previos.

* * *

Lexotanil

> Que tenía conocimiento de que en ocasiones el Sr. Kosciuck proporcionó medicamentos no proporcionados por el hospital a su madre,
>
> *Página 74 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Un solo día le di Lexotanil, que es un medicamento que tomaba en casa durante 20 años. Esto es algo que reconocí en la nota a Dirección del 26 de marzo. Adjunto Pruebas 4.3.12 de que se compraba con anterioridad y figura como "aceptado" por la siquiatra en Prueba ´4.3.11.

* * *

> oportunidades llevaba sus quejas a la dirección del hospital, amenazando que haría publico el trato que le daba el hospital a su madre

¿Esto lo dice porque agregaron mi nota del libro de quejas en la Historia Clínica? Simplemente reclame la Historia Clínica. Las amenazas de hacer publico ... yo lo haría público sin avisarle a nadie.

> Que en una oportunidad el Sr. Kosciuck (sic) se puso violento y tomó un cesto de basura, el cual tenía residuos patogénicos y lo dispersó por la habitación en la que se encontraba la madre de este ensuciándola. Que dicho suceso fue presenciado por el Dr. Néstor Schinocca [...]
>
> *Página 74 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Me suena a corporativismo médico. Supongo que ella no lo vio, pero Schinoccca si, sin embargo lo cuenta como si lo hubiese visto.

* * *

> "parte médico con fecha 20-04-2020 el cual consta en historia clínica con folio no 101, donde se pone en conocimiento de la Dra. Gaset respecto a el temor de la presencia del hijo de la Sra. Kuchasky."
>
> *Página 75 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Eso ya es un plagio de un capítulo de Los Simpsons. No me creo que Schinocca haya engañado a todos los médicos

Dr. Sebastián Gervasoni, Matricula no 152092

> “el cual en varias oportunidades se tornó violento verbalmente"
>
> *Página 76 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

De nuevo, para el horario de mi llegada casi no quedaban médicos. Mi forma de comunicarme con los médicos era dejar notas escritas en los sobrecitos del te, y pegados en la cama. Ver **Prueba 4.3.18**.

Por ejemplo, en la nota difamatoria de respuesta*Página 41 del archivo* ***HistoriaClinica.pdf*** (Fojas 21 y 22) a mi nota en el libro de quejas, dicen que soy un mal hijo que no va nunca. Pero cuando cuando se trata de difamar estoy siempre a toda hora y en todo lugar.

* * *

> observó al hijo de la paciente que tenía una bolsa en la mano con medicamentos, los cuales manifestaba el hijo que se los proporcionaba a la madre y pudo observar que algunos de ellos estaban vencidos.
>
> *Página 76 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Muy creible el invento de la bolsita, la confesión a viva voz y la visión de rayos X del médico.

* * *

> Ante esta explicación el hombre refería comprender, pero cuando se encontraba solo con la madre volvió a observárselo con una bola con medicamentos y se volvía a explicar que no debía hacerlo.
>
> *Página 76 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Yo no tenia ninguna bolsita de medicamentos, los medicamentos que tomaba quedaron en la mesita de luz sin necesidad de que yo este cargando nada en bolsitas. Y aún los tengo con las pastillas y las fechas de vencimiento para que chequeen si es que estaban vencidos. Además es imposible darle remedios vencidos si se compraban por PAMI cada mes. **Simplemente les dieron via libre para mentir sin siquiera repreguntar nada de lo que decían**.

Vuelvo a repetir, yo ya reconoci que le di un Lexotanil, eso lo comente con una enfermera, quien notifico al médico y me dijo que no haga eso porque los iban a culpar a ellos. Y como los enfermeros de la Unidad 4 se portaban 10 puntos, de ninguna manera me interesaba perjudicarlos.

* * *

> Que el hijo de la Sra. Kuchasky podría tener algún tipo de patología psiquiátrica, ya que sus actitudes y comportamiento no eran normales.

Cada vez me parece más creible la amenaza de Schinocca de querer hacerme pasar por insano.

3.5.2. Dr. Schinocca

> siendo las 12:20 horas del día 25 de mazo del corriente, observó cuando el hijo de la Sra. Margarita Kuchasky se puso violento y tomó la bandeja de la comida arrojándola, continuando con la bolsa de los residuos patogénicos de la habitación y los dispersó en la habitación ensuciando a su madre y distintos espacios del lugar. Que en aquella habitación aquel día se encontraba internada una mujer de apellido Lizardo.
>
> *Página 78 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Espero que mis distintos videos de ese día alcancen para demostrar que es mentira.

Lo que sorprende acá, y supongo que fue idea del Fiscal, decir que habia una mujer de apellido Lizardo, supongo que un médico no mentiría en cosas que se pueden

comprobar facilmente (chequear la HC de esa tal Lizardo) y la única utilidad de esa mentira se ve reflejada en la resolución del Fiscal cuando dice que yo era peligroso para mi mamá **y para terceros**.

* * *

> Que es muy posible que el hijo de la Sra. Margarita Kuchasky tenga alguna patología psicológica, ya que su comportamiento no es el de una persona en sus cabales.
>
> *Página 79 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

No me sorprende, fue lo que Schinocca dijo que haría.

* * *

> Luego del hecho antes mencionado, el hijo de la Sra. Kuchasky dejó de venir por haber comenzado la cuarentena decretada por el gobierno.

Evidentemente es mentira, sabía muy bien por qué deje de ir. Obviamente nadie le iba a repreguntar ¿pero Usted no fue el que prohibió el ingreso del hijo?

* * *

> Que desea aportar el dato, de que el hijo de Sra. Kuchasky habría realizado una publicado un en la página web denominada https://kosciuk.com.ar/muerte-en-el- hospital-pinero/

Pero que casualidad! El día 9 a las 10 de la mañana quiere aportar la URL que le pase al fiscal el dia anterior a las 17:41. Ver Sección 3.4.8. Me inclino a creer que este informe fue editado por el MPF.

Es muy increible que el médico se haya enterado en tan poco tiempo, y es más curioso como llego a encontrarlo... porque yo no era querellante aún y ni sabia el nombre del médico que me expulsó. ¿Quizá por eso Gaset dijo que yo amenazaba con hacerlo público? Pero si yo hice la página mucho despues, y sin necesidad de amenazar a nadie. Hice la página y listo.

3.5.3. El investigador

En *Página 79 del Archivo* ***MPF462972.pdf***, se ve captura de pantalla de la web donde hablo del telegrama y me quejo que pusieron cualquier nombre a mi madre. En un lado pusieron Leonor y en otro Elena. El investigador leyo Eleonor.

* * *

En *Página 80 del Archivo* ***MPF462972.pdf***, donde yo pongo "le afecto demasiado", el investigador traduce como "gran malestar". El Lexotanil es un sedante, solamente estuvo sedada mas de lo normal. Nuevamente, estoy reconociendo cosas (al 9 de junio).

* * *

Donde digo: "me robaron los remedios con la excusa de estar vencidos" el investigador traduce "los medicamentos incautados a él fueron desechados por estar vencidos".

Quiza luego de leer esto, fue el MPF inventó la declaración de Gervasoni.

* * *

En *Página 25 del Archivo* ***MPF462972.pdf*** donde cuento que el médico me expulsó por intentar mostrarle que tiraban la comida a la basura, el investigador traduce "relata el hecho ocurrido el día 25 de marzo del corriente, el cual consta también en la historia clínica."

* * *

Dudo mucho de la capacidad de este investigador en general y de su capacidad para comprender textos en particular.

3.5.4. Resumen

- El Fiscal decidió investigarme antes de que le lleguen "las sugerencias". ¿Armado?
- La invención de Lizardo parece ser un invento de la Fiscalía
- El “filtrado"de la URL de mi blog era innecesario, ya que la había enviado yo mismo a la Fiscalía
- La elección de los entrevistados también, como se ve en el video, se pudo haber entrevistado al de Seguridad o a esa tal Lizardo. Que de existir sería una testigo ideal para saber que paso con mi madre.
- El testimonio de Gervasoni y su visión de Superman no tiene mucha importancia. Seguramente lo llaman para hacer radiografias o cuando se rompe el tomógrafo.
- Schinocca, repite su mentira del 25 de marzo con el agregado de Lizardo, y la URL filtrada.
- Gaset, repite lo de Schinocca, supongo que por ser la Jefa y responsable por él.

3.6. Informe de perito forense

3.6.1. Comentarios generales

El informe de la perito forense solamente se basa en las partes que el Hospital decidió dejar de la Historia Clínica y en ninguna prueba por fuera de la misma.

¿Es normal que haya estado siempre en Clínica Médica siendo que segun los medicos estaba muriendo a cada día?

Y aunque la atención médica haya sido la mejor del mundo, que no lo creo, si a la paciente la privan de alimento desde el 24 de marzo hasta el 22 de abril, no es lógico esperar que la medicina haga milagros.

Asusta que la perito haya podido leer las páginas que faltan:

> la paciente fue evaluada diariamente, con evoluciones y asistencia de enfermería, desde la higiene personal a la asistencia en la ingesta diaria de las comidas

Sobre la estadía de mi madre en la Unidad 4 se podrian citar 2 testigos, Nora paciente que estuvo con mi madre hasta que aislaron a mi madre y Alejandra, hija de otra mujer que tambien estuvo internada en la Unidad 4.

Basandome en:

> **Valor probatorio de la historia clínica.** Aún cuando sea confeccionada en establecimientos públicos, la historia clínica es en esencia un documento particular reglado por disposiciones de orden público sanitario. Por ello, de acuerdo a lo establecido en el artículo 319 del CCyCN, su valor probatorio debe ser apreciado por el juez teniendo en cuenta, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen.[15]

Y desconocer lo sucedido es precisamente lo que planificó el Fiscal y lo que permitió la perito forense al no pedir pruebas.

Solamente con la intención de decir que mi madre ingresó en mal estado general es que pueden ignorarse fotos o filmaciones de mi madre durante su estadía en el Hospital. Ahí hubiese resultado obvio que el deterioro se produjo dentro del Hospital.

[15] Caramelo, Gustavo en https://salud.gob.ar/dels/entradas/historia-clinica

También se le olvidó a la perito forense el:

> ARTICULO 16. — Integridad. Forman parte de la historia clínica, los consentimientos informados, las hojas de indicaciones médicas, las planillas de enfermería, los protocolos quirúrgicos, las prescripciones dietarias, los estudios y prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas, debiéndose acompañar en cada caso, breve sumario del acto de agregación y desglose autorizado con constancia de fecha, firma y sello del profesional actuante.
>
> Ley 26.529[16]

3.6.2. Vida pre Piñero

Servicio 139 de PAMI. Creería que 200 médicos podrían confirmar que la única pasión de mi madre era la limpieza. Durante 2019 me animaría a decir que se llamaron **al menos** 300 servicios de ambulancia a domicilio (a veces se repetían los médicos), y todos podrán confirmar que mi madre se levantaba de la cama (donde esperaba la ambulancia) y caminaba hasta la cocina ida y vuelta. "Mire como camino", se quejaba, y era un problema de las discos de la columna que le hacían creer que caminaba tambaleandose cuando caminaba bien.

En casa **no estaba postrada ni necesitaba de nadie para hacer sus cosas**. No salía por el miedo a caerse.

3.6.3. Comentarios al informe

> Se ha dado vista al expte. de autos a fin de cumplimentar lo solicitado por esta Fiscalía.

Es una lástima que habiendo visto el expediente, no le haya interesado tener pruebas.

[16] http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/160432/texact.htm

Motivo de consulta: Síndrome Confusional agudo, fiebre. (27 de diciembre)

Creo que el sindrome confusional agudo es producto de algo, en este caso supongo que sería la neumonía. Paso lo mismo cuando la internaron por pancreatitis, o cuando perdió sodio y fue internada en el Santojanni.

Antecedentes patológicos: Gastritis, Esquizofrenia, Artrosis, TVP-trombosis venosa profunda. (27 de diciembre)

Esquizofrenia. Se adjunta Historia Clínica del prestador de siquiatría de PAMI que consta de solo 2 visitas, la segunda el 26 de diciembre de 2019 donde el Director de la Clínica no pudo hacer diagnóstico debido al cuadro clínico. Yo niego los diagnosticos de esquizofrenia simplemente porque ningun medico especialista le ha diagnosticado eso. Si los médicos del Piñero pudieron diagnosticar enfermedades siquiatricas mientras se cursaba un cuadro clinico, bien por ellos, pero creo que no corresponde ese procedimiento. Por el contrario, el antecedente de demencia senil, me fue dicho infinidad de veces por médicos de PAMI en los llamados al 139 con lo que lo considero aceptable.

Se desconoce evolución.

El diagnostico fue infección urinaria y el tratamiento con un antibiotico de 14 dias no sirvió. El medicamento fue suministrado por la farmacia del Hospital, quizá haya registro de eso. No hubo ninguna mejoría, por la misma razón se tuvo que repetir el ingreso a guardia el 19 de enero. Un médico de PAMI en visita a domicilio dijo que el tema era pulmonar y receto un remedio con el cual hubo una leve mejoria por 3 o 4 días.

Familiar refiere que no la puede cuidar.[17]

[17] *Página 58 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

No soy médico, obviamente no puedo cuidar a alguien con una infección que requirió internación.

> Familiar se retira sin dejar datos.[18]

Mi celular figura con fecha 20 de enero en *Página 29 del Archivo* ***MPF462972.pdf***. Al irme le deje mi numero al de Seguridad, porque el médico intentaba darla de alta. Además recibí 2 llamados telefonicos entre noche y madrugada del 19 y 20 para que la vaya a retirar.

La HC de 20/01/20 dice "se habla telefonicamente con el familiar". Evidentemente tenian el dato.

> 21hs: MEG-mal estado general- + Deshidratación, afebril sin edemas, obedece [...][19]

El 20 de enero 15:57 dice la HC que se la debe contener porque se quiere ir y ahora le aparece el mal estado general.

> Se interpreta el cuadro como NAC-Neumonía Adquirida de la Comunidad- se realizan HMC-hemocultivos- x 2 y tratamiento antibiótico AMS (Ampicilina Sulbactam).

Encontraron el problema. Ahora bien, ¿ya podemos justificar una parte de los delirios de mi madre como producto de una neumonía que inició en diciembre de 2019?

> Dependencia total. Síndrome geriátrico: Inmovilidad, Inestabilidad, Incompetencia intelectual, Incompetencia sensorial, Inanición, Indigencia, Infecciones. Anciana geriátrica con síndrome demencial y elevado riesgo social y pérdida total de funcionalidad, NO GERIATRIZADA.

[18] *Página 58 del Archivo* ***MPF462972.pdf***
[19] *Página 58 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

¿Dependencia total? ¿Indigencia? ¿Inanición? En prueba **Prueba 4.1.1** puede apreciarse la barriga de mi madre, y es más, la internación en el Piñero fue producto del sobrepeso, que sumado a la osteoporosis hacia que le doliera la cadera y no pudiera levantarse a orinar a la noche con lo que la mejor opción fue que durmiera con pañal. Si hubiesen resuelto el dolor de cadera (los de PAMI), no se hubiese llegado a ninguna infección.

Sobre la inmovilidad, presento la **Prueba 4.3.13**. Imagino que el tratamiento de kinesología era limitado a masajes sin bajarla de la cama.

No entiendo como paso de estar en casa y dedicarse a barrer todo el tiempo, a tener que estar geriatrizada en tan poco tiempo. No creo que una neumonía derive en geriatrico. Nuevamente recurro al testimonio de todos los médicos que concurrieron a casa durante 2019.

También es cierto que cuando el Hospital presenta el informe a PAMI, te recomiendan exagerar algunas cosas para dar prioridad. Lastima que no tengo forma de comprobar eso.

> 14-02: registros subfebriles. HMC y UC, en éste se rescata EVR (Enterococo Vancomicina Resistente), tratamiento con Linezolid- antibiótico- .(10-02-20).

El Linezolid fue **el** tratamiento que hizo efecto. Pueden verse los resultados en el video 4.1.1. Al menos le tengo un prejuicio positivo.

> 28-02: “el hijo medica por su cuenta con distintos fármacos entre ellos benzodiacepinas, se le explica los riesgos de dicha conducta, refiere comprender y se va” También:” conducta agresiva con el personal de salud” Se repite el 10-03.

Para desgracia de todos los que se quejan de la benzodiacepinas, que igualmente reconoci haberle dado una sola vez en la Nota dejada en Dirección, puede verse en el tratamiento indicado por la siquiatra en la **Prueba 4.3.11**, pero ya era comprado via PAMI con anterioridad, ver **Prueba 4.3.12** y **Prueba ??**.

Lo de la conducta agresiva lo dejo para que se presenten las supuestas victimas. Sería raro que se ofenda algún medico puesto que yo no iba al parte diario.

> 20-03: se acude al llamado de enfermería: el familiar por disconformidad con la atención estaba movilizando a la paciente por los pasillos del 1er piso para su traslado a algún otro sector del hospital (antes agredió verbalmente al personal de enfermería de la sala).
> 20

Ante la negativa de enfermeria de llamar a un médico (me preguntaron si era broma) y de querer acercarse a revisar a mi madre, le pregunte ¿que hago, la llevo a la guardia?, hace lo que quieras. Y si el medico no viene a la paciente, lo correcto (y que hacen también las ambulancias de PAMI) es llevar el paciente a la guardia.

Sobre las agresiones, recuerdo haberles, digamos, gritado (para parecer muy mala persona) algo como “ojalá les pasara a ustedes con su madre".

Volviendo al hecho de retirar la cama, no estuve mal al menos en el diagnóstico, ya que dicen que el 22 ...

> intercurrió el 22-03 con fiebre + hipotensión arterial,

Si intercurrió el 22 es porque no la controlaron el 20 antes de que yo la retire con rumbo a la guardia.

En la **Prueba 4.3.14** se lee “Clinica Medica Guardia, 22:04. Acudimos ...", como dije que iba a llevarla a la Guardia, llamaron a la Guardia, no planeaba llevarla a ninguna otra parte, ni mucho menos a mi casa como dijo el Fiscal.

> 25-03: “Continúa la conducta querellante y demandante del familiar injustificadamente

[20] *Página 59 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Curiosamente, cuando toda la Historia Clínica trata de hablar mal del familiar, y la perito forense se encuentra con la peor actitud realizada por el familiar, no pone ni un solo comentario. Porque lo que paso el 20 si lo comentó.

¿Dejar a una paciente sin familiares es buena práctica médica? ¿No es algo que deba ser mencionado?

Tampoco hace mención al aparato que se necesita para aspirar flema ¿se hace mención a eso en alguna parte de la Historia Clinica? Porque si nadie usa ese aparato, supongo que no se le puede dar de comer.

En la Historia Clínica con fecha 25 de marzo a las 11:50, *Página 141 del Archivo* ***MPF462972.pdf*** dice que se me explica el cuadro clínico, lo cual es mentira. En base a todos los videos de ese día se podrán dar cuenta que nunca apareció un medico hasta que viene el que me expulsa, porque si no, hubiese tenido ese mismo inconveniente mucho antes[21].

> 22-04: Paciente en mal estado general, VGI (escala de Valoración Geriátrica Integral) geriátrica, con múltiples síndromes geriátricos, comorbilidades, antecedentes patológicos con intercurrencias de índole infecciosa por gérmenes resistentes, por lo cual presenta alta morbimortalidad con pronóstico ominoso a corto plazo
>
> *Página 60 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Del mal estado habia pasado al regular y de nuevo al malo, ¿tendrá este último cambio algo que ver con la expulsión del familiar y las posibilidades de la paciente para alimentarse?

> Insuficiencia renal de probable etiología prerrenal. Paciente con pronóstico reservado. No se pudo contactar con el hijo, en varas oportunidades".
>
> *Página 60 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Mentira, exijo registro de llamadas por empresa telefónica.

[21] Todas esas afirmaciones deberían requerir la firma del familiar al que dicen que se le explicaron cosas.

¿Siempre tienen en clínica médica a los pacientes con pronóstico reservado? No debería esta conectada a uno de esos aparatos que constantemente miden presión y ritmo cardiaco. El que hace *beep*.

> 27-04: "mal estado general, sin familiar".
>
> *Página 60 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Los mismos que prohibieron el ingreso al familiar se quejan de la ausencia del familiar.

> 28-04: 00.20 hs: se acude al llamado de enfermería por encontrarse a la paciente sin signos vitales. 00.30 hs, se constata óbito.
>
> *Página 60 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Como dije antes, ¿desde que hora se encontraría fallecida? De haber estada conectada a un aparato, ¿se podrían haber realizado tareas de reanimación?

> 21-03: sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona A. y E. Coli, habiendo cumplido 7 días de antibióticos (finalizó por 14 días, incluyendo Vancomicina).
>
> *Página 61 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

El 20 fue cuando intente llevarla a la Guardia, posiblemente si no hubiese intentado ese traslado, no la hubiese visto ningún medico hasta el 25. Sábado y domingo no hay médicos y lunes y martes era feriado por el 24 de marzo.

> A su ingreso se calificó a la paciente con la escala de Valoración Geriátrica Integral (VGI) por las condiciones en que se hallaba
>
> *Página 62 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

¿Se la valoró mientras estaba cursando una neumonía que le habría provocado el sindrome confusional agudo?

> Se la describió en “mal estado general” y “en estado de abandono” desde el ingreso.
>
> *Página 62 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Deberia chequearse el estado general dia por dia, pero el estado de abandono creo aparece recién en el 20 de abril. Y en vistas del estado en que se encontraba mi madre al 28 de febrero, remito de nuevo al video **Prueba 4.1.1** estimo que el estado de abandono fue provocado dentro del Hospital.

> También se la ha descripto como paciente “deshidratada”, con “mucosas secas” .

3.6.4. Lo que se salteo la perito

25 de marzo de 2020. No cuenta para nada los supuestos hechos violentos realizados por el familiar. Ni la “sugerencia"de limitarle el ingreso.

20 de abril de 2020. Dice la Historia Clínica: “paciente que no se alimenta por sus propios medios [...] se decide colocar sonda. Pero, hacía casi un mes que se sabia!

3.6.5. Lo que falto a la verdad

> Según lectura de la copia de historia clínica, la paciente fue evaluada diariamente, con evoluciones y asistencia de enfermería, desde la higiene personal a la asistencia en la ingesta diaria de las comidas.
>
> *Página 60 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

¿Por qué dice que leyó *evoluciones y asistencia de enfermería* si falta eso mismo en los ultimos 46 días? ¿Cómo pudo leerlo? ¿De dónde? Que lo señale con el dedo!

El detalle pormenorizado de las hojas faltantes se encuentra en la Sección 3.2.1.

> Se tiene en cuenta que la señora Kuchasky, de 76 años de edad, presentaba previo a a su ingreso: inmovilidad (paciente postrada), incompetencia intelectual y sensorial (síndrome demencial), trastorno parcial de la deglución (motivo de internación: neumonía de la comunidad de tipo aspirativa), estado de abandono (según la transcripción de la epicrisis) y falta de contención social (familiar refiriendo al ingreso "no la puedo cuidar"

De este último párrafo de la perito, se puede sacar el siguiente patrón: todos los problemas son anteriores al ingreso al Hospital, excepto la enfermedad X que se contagió por culpa del familiar que la trajo por todos los problemas anteriores. La demencia senil se la dejo pasar, aunque no me parece una enfermedad terminal.

Paciente postrada: mentira, en casa no estaba postrada.

Incompetencia intelectual y sensorial: demencia senil, esto si me parece logico e intentaría llevarla para el tratamiento, tambien intentaría diferenciar lo que es producto de una infección clinica.

Trastorno parcial de deglución: en casa comia sin problemas y en demasía, en su momento fueron las galletitas de arroz y luego las Granix de salvado[22]. Tomaba mucho liquido.

Estado de abandono: mentira que fuera previo al ingreso. Si se refiere al mal diagnóstico dado por el Piñero el 27 de diciembre y la involución desde ese día, ahi si lo acepto.

Falta de contención social: Mentira. La cuide desde siempre, y en soledad desde el 1 de julio de 2015 cuando falleció mi padre. Así que un año más no haria problema. Como dije antes, yo no puedo (ni deberia) cuidarla cuando necesita atención médica. Si PAMI hubiese asignado el cuidador domiciliario por 8 horas, no habría intentado lo del geriátrico.

Se parece a una deducción antropologica, y aquí tambien resulta crucial que el Fiscal no haya querido pruebas de nada. Es mejor que la perito suponga lo que le conviene al Hospital que pedir

[22] De esto también podrían dar testimonio varios médicos

Lo que falta saber, es si ya tenia neumonía el 27 de diciembre de 2019, y no con posterioridad al 19 de enero de 2020. En la *Página 300 del archivo* ***HistoriaClinica.pdf*** escribí **Bronconeumopatía izquierda** aunque no recuerdo el por qué, ya que nos dieron de alta con infección urinaria.

> 2.- si la atención recibida por la paciente Margarita Leonor Kuchasky resultó ser la adecuada para el padecimiento que tenía y conforme los principios que rigen la medicina.

Sin los informes de enfermería de la Unidad 1 supongo que resulta dificil saber la evolución del paciente en el día a día, no sabemos si le daban la medicación, etc. Para ser obvios, no se sabe nada de lo que contenían esas hojas. No se puede saber si comía o no. En los informes de la Unidad 1 por ejemplo se lee que come acompañada por el hijo.

> 3.- si la Sra. Margarita Leonor Kuchasky era paciente sospechosa o confirmada de Covid-19 (coronavirus).

Sobre esto puede mencionarse la propia declaración del médico que me expulsó:

> En cuanto al nombrado, explicó que la madre de Kosciuk había estado internada en el Hospital Piñero, a la espera de pasar a un Geriátrico de PAMI, primero en la Unidad 4, luego en la Unidad 1, donde él resultaba ser Jefe, y luego en Sala Covid 19, donde finalmente falleció.
>
> *Página 1/2 del* Archivo **MPF497727.pdf**

y sigue:

> señaló que, la segunda semana del mes de marzo de 2020, la madre de Kosciuk pasó a una sala adaptada para pacientes con virus COVID-19 y a fines del mes de mayo del corriente año, falleció.
>
> *Página 1/2 del* Archivo **MPF497727.pdf**

No entiendo como es que teniendo abogado y al Director del Hospital no pudieron siquiera revisar las fechas en el sistema.

Sobre la causa en cuestión es curioso como una denuncia por amenazas es investigada con entrevistas y no con un pedido de informes a las empresas de telefonía:

> Es que las conductas inicialmente denunciadas por el abogado del Hospital Piñero, no han sido corroboradas a partir de las entrevistas mantenidas con los presuntos damnificados y con la prueba recabada.
>
> *Página 3 del* Archivo **MPF497727.pdf**

Siguiendo con el tema COVID, yo mismo vi la sala vaciada dias despues del fallecimiento de mi madre, y también cito a la persona encargada del Centro Coordinador de PAMI:

> Deberían entregarte información detallada en el hospital, no pude comunicarme aún con el médico/a tratante que estuvo hoy porque hubo modificiaciones en la sala y el personal.
>
> 29 de abril de 2020 a las 14:24, en la *página 3 del* Archivo **MPF497727.pdf**

En el caso de mi madre, fue movida de la Unidad 4 a la 1 para hacer lugar en la Unidad 4, pero es un simple traslado que no requirió ni el vaciamiento de la unidad ni el cambio de médicos.

Y por último, la preocupación por el cuerpo:

> Por otro lado, désele intervención al Cuerpo de Investigaciones Judiciales a fin de que personal de dicha dependencia proceda en forma urgente a realizar tareas de investigación tendientes a determinar donde se encuentra actualmente el cuerpo
>
> *Página 47 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

3.7. Resolucion MPF 462972

En *Página 234 del Archivo* ***MPF462972.pdf*** puede encontrarse la resolución del Fiscal. He aquí mis comentarios:

> los acusados aún no identificados llevaron a cabo actos para impedir el ingreso al Hospital de Agudos Piñero de Nicolas Kosciuk, hijo de Margarita Kuchasky, impidiéndoles que éste le preste asistencia a su madre
>
> *Página 234 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Es interesante este parrafo porque no logró averiguar quien me expulsó, pero llego a justificar la expulsión más adelante.

* * *

El tema de la denuncia contra la Policía no importa en esta sección.

* * *

> Recibida que fuera la presente denuncia y debido a la gravedad de los hechos ventilados, de manera inmediata procedí a solicitar al Juzgado PCyF Nro. 21 que libre una orden de allanamiento, *Página 234, 235 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Lástima que tardaron 7 días en hacerle llegar la denuncia, realizada el 5 de mayo.

* * *

> procedí a librar una orden de presentación a fin de que personal del [CIJ] se haga presente en el hospital y recolecte las pruebas vitales para la investigación. Tarea que se logró llevar a cabo sin ningún problema.
>
> *Página 235 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

No aclara si pidió el original o copias. El faltante de 1/4 de páginas parece que no es considerado problema.

* * *

> Kosciuk había hecho saber mediante distintos correos electrónicos que desconocía el paradero [...] Habiendo tomado noticia del paradero del cuerpo de la fallecida *Página 235 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Al Fiscal nunca le interesó hacer una autopsia por eso es que recién cuando yo pregunte donde estaba el cuerpo y por que no hacían autopsia, es que decidió averiguarlo. En pleno ASPO, mi madre estuvo 1 mes en la morgue del Hospital sin "ningun problema"

* * *

> le encomendé al Gabinete Médico del Cuerpo de Investigaciones judiciales que personal idóneo en salud examine todas las constancias médicas, incluida la historia clínica de la causante,
>
> *Página 235 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Dudo que personal idoneo no se haya dado cuenta que faltaban partes, y los comentarios de la perito donde afirma haber leido las partes que faltan. Que un perito mienta en un informe ¿qué delito es?. Mis comentarios al informe de la perito estan en la Sección 3.6.

* * *

> debo mencionar que de la sola lectura de la historia clínica [infinidad de problemas]
>
> *Página 235 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Según mi experiencia en internaciones el sindrome confusional es consecuencia de algo, supongo que alguna infección. ¿Es probable que el ingreso del 19 de enero de 2020, sea consecuencia del diagnostico (sin resultado exitoso) hecho en el mismo Hospital el 27 de diciembre del 2019?

Del ingreso a Guardia ese 27, no encontre nada que refleje el alta y las indicaciones médicas ¿es posible que falten esas hojas tambien?

> se observa del informe confeccionado por la distinguida médica legista, Dra. Laura Pereti que la difunta ingresó al hospital en un mal estado general de salud

Dejo como prueba el video del 28 de febrero de 2020, **Prueba ??**, en ningun momento entre el 20 de enero y el 28 de febrero, estuvo en el estado en que se la ve durante el video del día que me expulsan, ver **Prueba expulsion**. Por algo no se permite filmar, para que la realidad no contradiga lo que ponen los médicos.

* * *

> se determinó que los tratamientos médicos se ajustaron a la lex artis, es decir, que las prácticas médicas llevadas a cabo resultaban adecuadas para tratar sus padecimientos
>
> *Página 236 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

¿Como pudo determinar eso si faltan los ultimos 46 días de enfermería?

> concluyó que la difunta era una "anciana geriátrica, frágil, con comorbilidades motrices, intelectuales y sensoriales" y que "el pronóstico ominoso era factible"
>
> *Página 236 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Vuelvo al video del dolor de estomago, **Prueba ??**, a mi no me da la impresión de que esté a punto de morirse. ¿A ustedes?

Por otro lado, esta la parte de PAMI. Cuando uno hace el tramite del geriatrico, te dicen que cuanto peor la hagas parecer, mas prioridad va a tener. Entonces uno permite que exageren un poco para evitar que quede en el Hospital para "siempre".

> de la causante fue producto de un cuadro de “insuficiencia respiratoria aguda".

Bien por el Fiscal, la perito no menciono eso.

* * *

> La conducta de los médicos se basó en los principios que rigen la lex artis

Expulsar al familiar no creo que este dentro de la *lex artis*

* * *

> el querellante ha manifestado que su madre podría haber fallecido producto de desnutrición ya que el personal hospitalario no le daría los alimentos necesarios para subsistir, o bien producto del virus Covid-19. Estas circunstancias han podido ser descartadas sobremanera con todos los elementos existentes en autos.

Los elementos que hay en autos son: una historia clinica incompleta y adulterada, y declaraciones del mismo médico que la adulteró, la jefa de este médico y otro médico con visión de Rayos X. Sin olvidar el informe completo sobre una Historia Clínica incompleta. Y mis pericias siquiatricas y sicologicas.

No figura siquiera el peso que tenía la fallecer. Que por cierto, al momento del ingreso seria de 70 kilos para una talla de 1.55m.

Sobre la alimentación no figura que el 24 de marzo no me dejaron ingresar a darle de comer, a la noche me dijeron que no vaya y tiraron la comida a la basura, y el

25 cuando trato de comentarle estos hechos al médico, me termina expulsando. La preocupación por que mi mama coma para mi eran nulas.

Por otro lado, no cierra que le hayan puesto sonda porque no podia alimentarse por sus propios medios, pero recién un mes despues de que me expulsaron, durante ese mes ¿se alimentó por sus propios medios? ¿Y quien usaba el aspersor? ¿Ella misma?

* * *

> que surge de los elementos de prueba en autos - sumado a los propios dichos del querellante frente a las médicas del gabinete psicológico y psiquiátrico del CIJ- una serie de actitudes violentas e inadecuadas por parte del Sr. Kosciuk, como ser suministrarle medicamentos a su madre si autorización médica alguna, arrojar residuos patológicos por la habitación impactando algunos de ellos sobre la difunta, haberle dado comida que se encontraba en el sesto de la basura, entre otras actitudes. Reitero, todo esto dicho por el propio denunciante, tanto en su entrevista con el CIJ como en su blog personal

No entiendo por qué dice que dije cosas que no dije, ni tampoco cosas que no escribí. No entiendo un Fiscal puede poner tantas mentiras en una resolución.

1. lo unico que reconozco es haber dado un Lexotanil, hecho reconocido el 26 de marzo en mi nota al director. Pero como se puede ver, el Lexotanil estaba recetado. Prueba 4.3.11.

2. lo de arrojar residuos, fue invento del médico, dejo una vez mas la Prueba 4.1.8 y todos los videos del 25 de marzo donde se ve la comida sobre la mesa y a la espera de que venga el medico para que lo vea.

3. lo de "haberle dado comida que se encontraba en el sesto de la basura.[es] una injuria inventada por el Fiscal Riggi. La mentira de Riggi se podrá comentar en otra sección.

4. no, yo no dije nada de eso. Y mucho menos escribiria mentiras en mi pagina web. Faltaba poco para que dijera que hice solicitadas en Clarin y Pagina 12.

Supongo que pone tantas mentiras porque después nadie lee nada excepto la resolución.

* * *

Esto es raro:

> Asimismo, el Sr. Kosciuk también ha denunciado que el personal del hospital le había prohibido la entrada el establecimiento, impidiéndole asistir a su madre. Esta circunstancia queda zanjada con lo dicho por los médicos mas arriba, toda vez que la presencia del Sr. Kosciuk con sus reiteradas y continuas actitudes presentaba una amenaza para el resto de los pacientes así como también para su propia madre.

Para el resto de los pacientes... supongo que será la mujer de apellido Lizardo que no se sabe quien es.

Y parece sugerir que me expulsaron por todas esas mentiras que dicen los médicos, pero más abajo pone:

> A su vez, esto coincide con la respuesta dada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la cual informó ante el requerimiento de este fiscal, que el Sr. Kosciuk se comunico varias veces con dicho organismo ya que en el hospital denunciando no le permitían el acceso por considerarlo problemático. Ante las gestiones del organismo, se logró que se le permita el acceso al establecimiento, conforme consta del informe.
>
> *Página 239 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Miente, la Defensoria no logró nada. La Defensoría solamente hablaba por telefono con el Hospital y me enviaba mails como este:

> Hola Nicolás, espero que estes bien. Ayer nos comunicamos con el director, quien dijo que no habríua problemas para que veas a tu madre. Te pido que si llega a haber algún inconveniente, nos lo hagas saber. Saludos

Página 3 del Archivo ***mails-con-defensoria.pdf***, fecha 27 de marzo de 2020, 12:22

Sin embargo al ir no me dejaban pasar. Tecnicamente fui expulsado pero tenía permiso del Director para ingresar. El medico que me expulso dijo ademas que deje de ir por la cuarenta. No se sabe quien me expulso, fui expulsado pero tenia permiso para ingresar por parte del Director. A mi no me resulta zanjado nada.

> Habida cuenta de lo mencionado, entiendo que resulta necesario destacar que de la entrevista que el denunciante mantuvo con las psiquiatras y psicólogas del CIJ, las especialistas llegaron a la conclusión de que el nombrado Kosciuk padecería de un trastorno paranoide de la personalidad

Yo no se si esta inventado o no, siendo que el Fiscal dice que dije cosas que ni siquiera aparecen en los informes.

Por ejemplo, "son capaces de culpar a los demás de sus propios errores", es que alguno de lo que declaré es mentira. El Fiscal cree las mentiras del medico sin pruebas, sin embargo mis videos no valen nada.

> Gran parte de los puntos aquí detallados, fueron compartidos por mi colega Dra. Amil Martín en la denuncia penal que iniciara el querellante contra el suscripto, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, así como también luego sostenidos por el Sr. Fiscal de Cámara Norte Dr. Eduardo Riggi,

En esa resolución de Riggi es donde leyendo la pericia siquiatrica que Rozas le paso. ¿No es turbio eso? “Te paso la pericia siquiatrica que le mande hacer al que me denunció por encubrimiento” y Riggi, como colega, se inventó lo de darle de comer comida sacada de la basura.

Entonces, tenemos un Fiscal Rozas que no me quiere dejar querellar, me hace una pericia siquiatrica, le pasa esa pericia al que lo investiga (Riggi), el que lo investiga

algo en la resolución, le pasa la resolución a Rozas, y Rozas usa como prueba algo que se invento Riggi.

Es un detalle, pero todo tiene este funcionamiento donde se puede archivar porque "la moneda cayó caraz el Fiscal de Camara lo convalida alabando la gran imparcialidad.

3.8. MPF 474350. Denuncia cajoneada contra PAMI

3.8.1. 11 de junio de 2020

Hice una denuncia contra PAMI con la esperanza de que cayera en otro Fiscal.

La denuncia contra PAMI decidieron enviarla a Nación pero nunca la enviaron[23].

* * *

El Juzgado 26, Secretaria 51, en cédula electrónica de la denuncia **contra PAMI** decide:

> DECLARAR LA INCOMPETENCIA de este Juzgado [...] y REMITIRLA a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional a fin de que se desinsacule el Juzgado Federal que deberá continuar con la investigación.
>
> *Página 128, 129 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Como era de esperar, nadie envio nada a ninguna parte. Recién en Septiembre, gracias a insistir a que la envien, la terminaron enviando. Supongo que no querían que nadie investigue nada.

* * *

[23] Cédula Electrónica en *Página 127 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

El Juzgado 26, Secretaria 51, en cédula electrónica de la denuncia **contra PAMI** decide:

> DECLARAR LA INCOMPETENCIA de este Juzgado [...] y REMITIRLA a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional a fin de que se desinsacule el Juzgado Federal que deberá continuar con la investigación.
>
> *Página 128, 129 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Como era de esperar, nadie envio nada a ninguna parte. Recién en Septiembre, gracias a insistir a que la envien, la terminaron enviando. Supongo que no querían que nadie investigue nada.

3.8.2. Septiembre de 2020

Luego de insistir en el Juzgado, recién en septiembre de 2020 logré que enviaran la denuncia. ¿Pensaban que Nación iba a investigar en serio?

No se de quien era la responsabilidad de enviar la denuncia a la CCC.

3.9. MPF 494439. Falso testimonio

Archivada la denuncia de abandono de persona, hice la denuncia de falso testimonio contra los médicos por todo lo que habían dicho en el "Informe del investigador", ver Sección 3.5.

Mi idea era que si lograba demostrar que mintieron en el informe, también habrían adulterado la Historia Clínica puesto que el relato era el mismo.

3.9.1. 14 de agosto de 2020

Según una resolucion, este dia hago la denuncia. Basicamente:

- El relato de Schinocca (y Gaset, la Jefa) son mentira, mi prueba son los videos de ese 25. Tambien podría entrevistarse por ejemplo al de Seguridad que se ve en el video, quizá lo dejaron porque el corporativismo es solo entre médicos.

- Es mentira que haya existido una mujer de apellido Lizardo en la habitación con mi madre, ella estaba sola desde hacia una semana. Sospecho que fue un invento autorizado por el Fiscal con la garantia de que nadie investigaria ese nombre.

- La declaración de Gervasoni, con su visión de rayos X es bastante increible. El dijo que yo tenia remedios vencidos, eso de demostraria que es mentira simplemente chequeando en PAMI.

- Que el medico haya querido aportar una URL que pase el dia anterior al Fiscal me parece que es una muestra de los arreglos MPF - Hospital (medicos).

3.9.2. 21 de agosto de 2020

El Fiscal Galante archiva con la excusa de que:

> La evidencia colectada por su escaso valor probatorio [...]

Me da bronca que el testimonio de los médicos no tenga una sola prueba mas que su propia imaginación y mis pruebas sin embargo sean escasa. Por otro lado, hay pruebas que tiene que investigar el propio Fiscal, yo no puedo presentar la Historia Clínica de alguien que quizá no existe, para demostrar que no estaba en el Hospital.

3.9.3. Primera revisión

Solicito revisión y milagrosamente aceptan, lo malo es que volvió a caer en el Fiscal que armo esa entrevista con los médicos, y si no quiso recibir pruebas en la denuncia de abandono, menos va a querer pruebas en este caso.

3.9.4. 23 de septiembre de 2020

Escribe el Fiscal Rozas:

> Una vez reanudada la investigación, el caso fue asignado a la fiscalía a mi cargo por encontrarse de turno al momento de la denuncia, conforme los reglamentos de asignación de casos.
>
> *Página 2 del Archivo* ***MPF494439.pdf***

No se si haber denunciado al Fiscal sirve para que el Fiscal se aparte por propia voluntad, por mi parte yo estoy en contra de que Rozas se acerque a mis denuncias.

* * *

> motivo por el cual el quien suscribe, ha evaluado la totalidad del evidencias colectadas en ese caso y resolviera su archivo, habiendo valorado positivamente la prueba que aquí se cuestiona.

¿De que prueba habla? Los denunciados simplemente hablaron sin dar prueba alguna. Estoy acostumbrado a las peliculas donde "uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario", sin embargo no veo que hayan aportado ninguna prueba. Entiendo que los medicos pueden hablar lo que quieran, pero que el Fiscal lo considere como prueba, ya es otro tema.

* * *

Sigue Rozas:

> Apoyando dicha postura, esa resolución examinó los testimonio de los médicos denunciados, y se entendió que los mismos se apoyaron y respaldaron en constancias y documentaciones; como por ejemplo la historia clínica de la paciente, donde se daba cuenta de las acciones realizadas

> por el aquí denunciante y del tratamiento recibido en el nosocomio. Es decir, no solo se ha tomado en consideración lo dicho por los galenos, sino que esos dichos han sido contrastados y convalidados con el resto de la prueba reunida.

El Fiscal entrevista a los mismos que escribieron la Historia Clínica, y usa ese testimonio para convalidar lo que dice la Historia Clínica. Eso, en lógica, debe ser una falacia.

Esto es ridículo: "sino que esos dichos han sido contrastados y convalidados con el resto de la prueba reunida". Es como decir, los dichos de A han sido contrastados contra lo que escribió A. Parece ser que a mayor cantidad de entrevistas a A, mayor será la veracidad de la prueba. Por más que todo sea fantasía de A.

> En definitiva, a la fecha, resultaría por demás contradictorio establecer ahora que dichos testimonios adolecen de vicios cuando dos fiscales, uno de primera instancia y luego el Sr. Fiscal de Cámara de la zona Oeste, determináramos, como MPF que el hecho del abandono de persona no existió y que la prueba que motivó dicha conclusión ahora es falsa.

Pues lo lamento por el personal del MPF, si me hubiesen solicitado pruebas, cosa a la que se negaron, podrían haber visto mis videos mucho antes y podrian haber puesto en duda lo que escribio y habló el médico.

> Por otro lado, personal de ésta fiscalía ha procedido a analizar el enlace aportado por el denunciante (https://youtu.be/jzmWhk7Fs-Y), el cual dirige hacia la web "YouTube" donde se suben y comparten videos con toda la comunidad de internet, no observando un hecho que se vincule con este caso ni tampoco lográndose determinar la fecha de grabación del mismo

¿Pero como? Acaso no es mi madre la que se ve en el video? Y ese médico no es Schinocca? Y el Hospital no es el Piñero? Y no pudieron determinar la fecha? Incluso

con el audio, sin necesidad de ver el video, se aprecia que el conflicto gira alrededor de una comida sacada de un tacho de basura con bolsa roja.

Si el mismo médico reconoció que lo tengo filmado en video!

> Ante ello, lo invitó a retirarse de la Sala, situación la cual fue grabada por el denunciado con un dispositivo electrónico
>
> *Página 2 del* Archivo **MPF497727.pdf**

3.9.5. 1 de octubre de 2020

El Fiscal Lapadu no convalida el archivo, de nuevo vuelve a Rozas.

> el caso MPF 462972 tramitó ante ésta Fiscalía a mi cargo, motivo por el cual me encuentro completamente familiarizado con el expediente y con la prueba allí recabada.
>
> *Página 10 del Archivo* ***MPF494439.pdf***

Como bien dice Rozas, él ya tuvo a su cargo el caso MPF 462972, donde se negó a recibir pruebas, con lo cual es poco creible que en esta instancia vaya a aceptar pruebas de que contradigan lo que ya decidió resolver sin pruebas.

* * *

Dice Rozas (creo que confunde el numero de causa):

> " y esto es toda la documentación recolectada en el caso MPF 494439, que apoya a la versión dada por los Dres. Schinocca y Gaset"

Mi hipotesis es asi, Schinocca me expulsó como se ve en el video y adultero la historia clinica, luego lo entrevistan a Schinocca quien no va a declarar contra si mismo, ni veo por qué diría la verdad.

Me pregunto ¿que es lo que hace no creible al video que tengo filmado? Se ve claramente que Schinocca expulsa al que esta filmando que casualmente soy yo.

Tampoco se entiende por qué el Fiscal no pregunta al medico si ese es el y si reconoce la escena. Si el médico ya reconoció que lo filmé.

* * *

Supongo que Rozas no vio el video porque dice:

> Es que en definitiva no hay terceros testigos hábiles que puedan dar fe de la versión del aquí denunciante sobre lo que pudo ocurrir dentro de la habitación donde se encontraba alojada su madre.
>
> *Página 10, 11 del Archivo* ***MPF494439.pdf***

¿Es que el personal de seguridad que aparece en el video no sirve como testigo? ¿Y la mujer de apellido Lizardo? Copio de nuevo lo que dijo Schinocca:

> Que en aquella habitación aquel día se encontraba internada una mujer de apellido Lizardo
>
> *Página 78 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

¿Y donde está Lizardo? No tenemos un testigo, sino dos.

3.9.6. 10 de octubre de 2020

Ya en la confirmación del archivo el Fiscal de Cámara:

> En efecto, incluso si pudiese determinarse la fecha y hora de producción del video aportado en el marco de la denuncia de fecha 14 de agosto de

> 2020, éste presenta una ventana temporal acotada (de un minuto treinta y un segundos) que puede no coincidir con las conductas relatadas por los galenos, limitándose así su valor positivo a los efectos de corroborar los extremos denunciados.
>
> *Página 12 del Archivo* ***MPF494439.pdf***

¿Es que intentaron averiguar fecha y hora? ¿Es que el Gabinete de Informática no pudo determinar la fecha?

La excusa de la ventana temporal acotada supongo que quiere decir que los hechos que dicen los médicos pudieron producirse antes o despues de lo que hay filmado.

Consideremos las dos opciones sin necesidad de poner hora exacta:

a) si el video es anterior a lo que relata el médico, significa que yo fui expulsado antes de que pasen las cosas de las que me acusa el médico. Por tanto es mentira que yo haya estado en el hospital para hacer las cosas que relata el médico.

b) ahora supongamos que el video es posterior, lo cual tampoco es creible puesto que el médico ya me habría hecho retirar y yo no podría seguir filmando.

Ahora usemos la ventana temporal con los supuestos actos violentos:

a) si yo arrojé comida y basura por la habitación, sobre mi madre y sobre la misteriosa mujer de apellido Lizardo, **antes de lo que se ve en el video**, ¿por qué la comida está en la bandeja, la habitación limpia, el tacho en el baño y no se ven rastros de Lizardo?

b) si en cambio los supuestos actos violentos **son posteriores a lo que se ve en el video**, ¿por qué entonces me está expulsando con anterioridad? No sueña logico que primero pase la consecuencia (llamado a seguridad y expulsión) y la causa sea posterior (los actos vandálicos). ¿Se trata de una expulsión por crímenes futuros como sucede en un capítulo de la serie Futurama?[24]

[24]En este episodio, Fry deja su trabajo como repartidor en Planet Express y busca un nuevo trabajo como oficial de policía. Finalmente es ascendido a la División de Crímenes en el Futuro, donde se predice un crimen cometido por Bender, su mejor amigo, que le coloca en un dilema que pone las vidas de sus amigos en peligro. https://es.wikipedia.org/wiki/Law_and_Oracle

Como puede apreciarse todas las resoluciones ponen excusas teóricas por sobre la investigación práctica que consistiría en preguntarle al médico ¿este es Usted?

Y por lógica, no pude haber sido expulsado dos veces el mismo día. ¿Cuantas veces dice Schinocca haber llamado a seguridad para que me retiren? Una? Dos? Diez? Casualmente tengo un video de Schinocca expulsandome. Creo que hay que poner mucho esfuerzo intelectual para decir que no son el mismo suceso.

Tampoco se si del video se desprende algún delito del estilo como amenazas o abuso de autoridad.

3.10. Denuncia 641840 - MPF 479852

Resolución y Dictamen de Revisión figuran en *Archivo* ***DEN641840.pdf***.

Ya había pasado un mes de la denuncia de abandono y aún no me habían llamado para reconocer el cuerpo, con lo que para mi, no iban a hacer autopsia. Si por razones de COVID no pensaban manipular el cuerpo, bien se podría haber pesado la bolsa, pero también haria falta reconocer el cuerpo.

3.10.1. 11 de junio

Hago la denuncia por encubrimiento (textuales palabras) contra Rozas por teléfono. Solo tengo las resoluciones donde no figura la palabra autopsia.

3.10.2. Comentarios a la resolución

> Esta Fiscalía solicitó la totalidad de lo actuado en el caso MPF 462972, a fin de evaluar los hechos denunciados.

Solicitaron todo el expediente, y vieron lo que quisieron ver.

* * *

> la primer denuncia en trámite ante la Fiscalía nro. 20. Se inció el día 11 de mayo de 2020

Siempre me va a llamar la atención de que digan se inició el 11 y luego presuman de celeridad, cuando la denuncia se hizo el 5 de mayo.

* * *

> "resguardar la prueba que pudiera existir de ello"

No entiendo a que se refiere. Frase de relleno.

* * *

> Dio intervención al Cuerpo de Investigaciones Judiciales de este MPF a los efectos de que se presente en el nosocomio denunciado, orden de presentación mediante, y obtenga copia de la historia clínica de la occisa

Incorrecto. Pidió el original.

* * *

> Dispuso que personal de esa dependencia se entreviste con el denunciante a los efectos de que éste brinde un pormenorizado relato de los hechos denunciados, y aporte la prueba que pudiera tener en su poder.

Como figura más arriba, pidieron TODO el expediente. Leyeron lo que pidio el fiscal, pero no les importo que no se haya cumplido. Le escribi a Amil Martin para que me señale donde vio las pruebas aportadas y la entrevista, pero me derivó no se a donde.

* * *

> Habida cuenta de dichas medidas, y obtenida la historia clínica de mención, se dispuso que personal del gabinete médico del CIJ realice un análisis de dichas constancias

No se si es necesaria la transcripcion del informe de la perito en una causa de encubrimiento. Deberia revisarse el expediente para ver si le avise que la historia clinica podría estar adulterada. En ese momento solo creeria que estaria adulterada toda la parte a parte de mi expulsión solo para justificarla.

* * *

> a que al día siguiente de recibida la denuncia que sirviera de origen al caso MPF 462972, el fiscal a cargo determinó los hechos a investigar y dispuso medidas urgentes de prueba, cumpliendo con su función, dada la gravedad del caso.
>
> *Página 4 del* Archivo **DEN641840.pdf**

De nuevo con la urgencia. ¿Dada la gravedad del caso esperaron desde el 5 de mayo?

* * *

> con los fines de hacerse de la historia clínica, a los efectos de valorar la posible responsabilidad penal del Hospital Piñeiro

De nuevo nadie está revisando si la Historia Clinica esta completa, ¿no debería haber primero un analisis de forma de parte de la perito?

* * *

> quedando abarcada en el segundo de ellos, la posibilidad del fallecimiento por desnutrición -luego desmentida en dicho informe-.

Es raro porque el informe no explica como era alimentada, si se sabe cuando, en teoría, le pusieron la sonda, pero antes no.

* * *

> la fiscalía actuante dispuso de manera urgente la averiguación del paradero del cuerpo en cuestión

Inmediata es casi un mes.

* * *

No hay mucho para comentar sobre la resolución. Si no pudieron encontrar que no habian pruebas menos iban a darse cuenta de que faltaban partes.

3.10.3. Dictamen de Revisión

Este pedido de revisión es de fecha 23 de julio de 2020, es interesante como el Fiscal denunciado, luego de hacerme la pericia siquiatrica se la pasó al Fiscal que escribe esta resolución. La anterior resolución era de fecha 1 de julio por lo que aún no estaba subida en el sistema la pericia.

No veo que aporta al Dictamen una pericia siquiatrica del denunciante, quizá sea lo normal ya que en todos lados se ha usado.

> " Incluso, se advierte que en una oportunidad el Sr. Kosciuk fue expulsado del hospital por haber sacado deshechos de la basura"

¿Donde se advierte? ¿Expulsado por quien? Nadie reconoció haberme expulsado.

* * *

> [...] del informe presentado por el Gabinete Mèdico Legal y Psicològico del Cuerpo de Investigaciones Judciales del MPF surge que el propio denunciante reconoce haber suministrado a su madre una medicación que no correspondía y dado comida del día anterior que estaba en el cesto sobre la mesa de la habitación por considerar que estaba ïntacta".

Lo del medicamento ya es reiterativo, pero todo el que comento algo de mi me acuso de darle un remedio que tomo durante 20 años en casa y estaba indicado por la siquiatra.

Lo de darle comida sacada de la basura es invento del Fiscal, supongo que puedo haber "leido malz por "accidente" este fragmento:

> yo la veía nerviosa (...) tuve algo con los de seguridad, sacudí una puerta y puse la comida del día anterior que estaba en el cesto sobre la mesa de la habitación porque estaba intacta y me echaron del lugar (...) no soy un violento
>
> *Página 213 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Lo de tener algo con los de seguridad no se si se refieren a algo romantico o que. Sacudir la puerta para que llamen a seguridad fue el 24 de marzo al medio día. Poner la comida que encontre en la basura en la mesa fue el 25.

Si el Fiscal Riggi no elaboro su injuria a partir de este fragmento, no tengo idea de donde pudo inventar eso.

Lo grave de esta injuria es que la van repitiendo, luego le pasan esta resolución a Rozas y éste usa la mentira en su resolución:

> "haberle dado comida que se encontraba en el sesto de la basura"
>
> *Página 236 del Archivo* ***MPF462972.pdf***

Y asi, una denuncia de abandono de persona se transformó en una competencia de quien difama mejor al denunciante.

3.11. Denuncia 713875

Esta es la denuncia por el faltante de partes de la Historia Clínica.

3.11.1. 5 de febrero de 2021

Lo curioso de ésta resolución es que a las 12 horas me contactaron por mail en el que me pidieron la Historia Clínica, y se las pasé.

> "necesito que me envio la historia clinica nada mas. muchas gracias"
> *Página 1 del Archivo* ***DEN713875.pdf***

Dos horas después terminaron archivando. La resolución es breve y se puede citar completa:

> Toda vez que la presente denuncia, guarda vinculación con los hechos investigados en el marco del MPF 462972, que tramitó por ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 20, y siendo que el mismo se encuentra archivado y convalidado dicho archivo por el Fiscal de Cámara, entiendo que corresponde estar a lo allí dispuesto, , sin más trámite, de conformidad con lo previsto en el art. 211 del Código Procesal Penal de la C.A.B.A

Imagino que me pidieron la Historia Clínica pensando de que yo no la iba a tener, y entonces podrían archivar por falta de pruebas o algo así. Como tenía las pruebas tuvieron que archivar con otra excusa.

Para saber que las denuncias se relacionaban no era necesario pedir la Historia Clínica. Por otro lado, acá decidieron archivar por "vinculación" mientras que la denuncia por falso testimonio (Sección 3.11)

3.11.2. Pedido de revisión

> Asimismo, no surge del expediente que tramitó ante la Fiscalía N° 20 ningún indicio de que lo denunciado así fuera

Desconozco como es que se debe denunciar que faltan partes de una Historia Clinica. Obviamente no puedo señalar con el dedo las cosas que faltan. Es tan ridículo como que le pedian la billetera al que denuncia que se la han robado.

Por otra parte, yo solo pude detectar que faltan partes de una unidad porque estaban los de la otra. No se que otras partes pueden estar faltando o si es normal que haya tan pocos laboratorios. Lo que yo pude detectar esta esta.

> y, de hecho, la información reunida fue por demás suficiente para determinar que los médicos que asistieron a la Sra. Kuchasky obraron diligentemente.

Significa esto que no importa cuanto se elimine de una Historia Clinica siempre que lo que quede "sirva para determinar".

¿No es mas sospechoso que hayan podido determinar algo en base lo que quedó? Sería mas honesto si lo dijera la perito: "faltan partes pero aún así yo puedo inferir que...". Pero la perito lo pasó bien por alto.

Lo otro a mencionar es que precisamente falta la ultima mitad, en la que yo no estuve y no hay videos ni fotos.

3.12. Denuncia MPF654300

La denuncia de hurto realizada el 4 de marzo de 2022 se corresponde con la sospechosa aparición de la denuncia MPF 654300. Durante varios meses de 2021 estuve enviando una denuncia similar a que puede verse en el Archivo **Gmail-Historia-Clínica-20220113.pdf** sin respuesta alguna.

3.12.1. 12 de noviembre de 2021

Una abogada me redactó un texto solicitando actuaciones, puede verse en el Archivo **SolicitoActuaciones.pdf**. Se envió ese PDF a las 4 UIT y a la Fiscalia 20. No respondió nadie de los que tuvieron denuncias mías.

3.12.2. 17 de noviembre de 2021

Aparece alguien[25] de la UIT Sur, cuya única función fue comprobar que yo tuviese la copia de la Historia Clinica, ver capturas de Whatsapp de **Prueba 4.3.10**.

3.12.3. 23 de noviembre de 2021

Luego de verificar si tenia copia de la Historia Clínica (al igual que paso en febrero de 2021 con la Denuncia 731875, ver 3.11.1) me termina derivando a la Fiscalía 40, con una denuncia que parece ser que tenían desde el 3 de octubre de 2021, ver **Prueba 4.3.9**.

No se como funcionan las cosas en el MPF, si la denuncia la tenia la Fiscalia 40 y mandaron a la UIT a investigar. O la UIT Sur investigo y le paso

4. PRUEBA

4.1. Videos

4.1.1. Dolor de estómago

Video: https://youtu.be/LGlQeucRnk4. 18 de febrero de 2020.

[25] Lo que yo llamo un infiltrado

Para demostrar el estado en que estaba mi madre en la Unidad 4.

4.1.2. Arreglando una puertita

https://youtu.be/-M8XJTqQB7Y. 22 de marzo de 2020 a las 13:52:46

Video arreglando la mesa. No siempre estaba "vandalizando cosasçomo dicen los médicos.

4.1.3. En búsqueda de personal de enfermería

https://youtu.be/OLIBWl9OLN8. 25 de marzo de 2020 a las 10:47

4.1.4. Pies hinchados ¿trombosis?

https://youtu.be/Z19mfmTO8JA. 25 de marzo de 2020 a las 10:56

A veces el suero se perdía sobre las sábanas otras veces estaba colocado en lugares raros. Es llamativa la hinchazón. Desde el cambio a la Unidad 1 empeoró bastante respecto a la **Prueba 4.1.1**.

4.1.5. Celular faltante

Video: https://youtu.be/ldJXbaieSoE. 25 de marzo de 2020 a las 10:58.

Puede apreciarse también que la cama de junto, está sin preparar.

4.1.6. Esperando al médico

https://youtu.be/Vs0UkM5Z3oc. 25 de marzo de 2020 a las 12:27.

4.1.7. Se vienen problemas

https://youtu.be/mojAZafiMhY. 25 de marzo de 2020 a las 12:32.

4.1.8. Expulsión

https://youtu.be/jzmWhk7Fs-Y. 25 de marzo de 2020 a las 12:35.

Momento de la expulsión. Se intenta demostrar que la comida seguía en las bandejas, nunca se ha revoleado ni comida ni basura, ni por la habitación ni por encima de ninguna persona.

También puede apreciarse que la cama de junto sigue vacía. Y el cartel de aislamiento KPC en la puerta.

4.2. Audios

4.2.1. Comentarios Unidad 1

Comentarios de un enfermero de la Unidad 4 sobre el sistema de timbres de la Unidad 1. Dice que los timbres no tienen sonido, y que el aparato en enfermería está oculto tras un mueble. No me quiero imaginar el tiempo de reacción ante una emergencia.

https://soundcloud.com/nhkosciuk/comentarios-unidad-1

4.3. Fotos

4.3.1. Trombosis

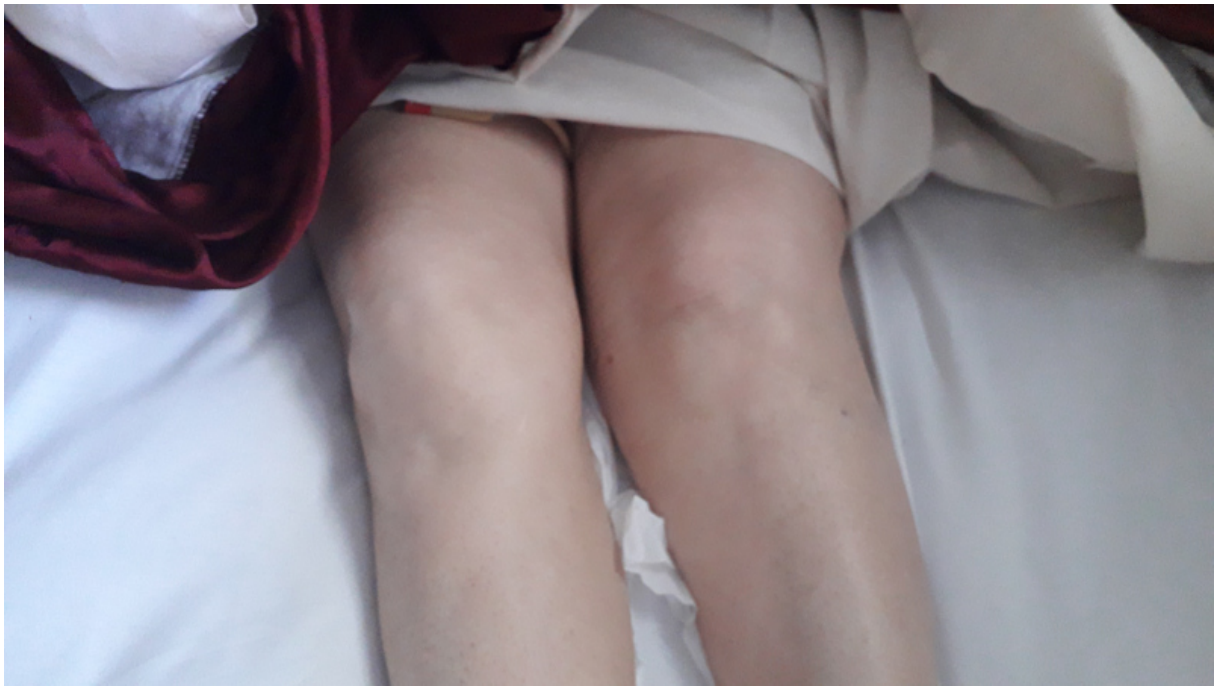


Foto del 22 de marzo. Casi 2 meses de internación, me da la impresion que la pierna izquierda (derecha en la foto) está hinchada.

4.3.2. Brazo



Foto del 23 de marzo. No por las heridas sino por lo gordo.

4.3.3. Explicación del COVID en la Guardia

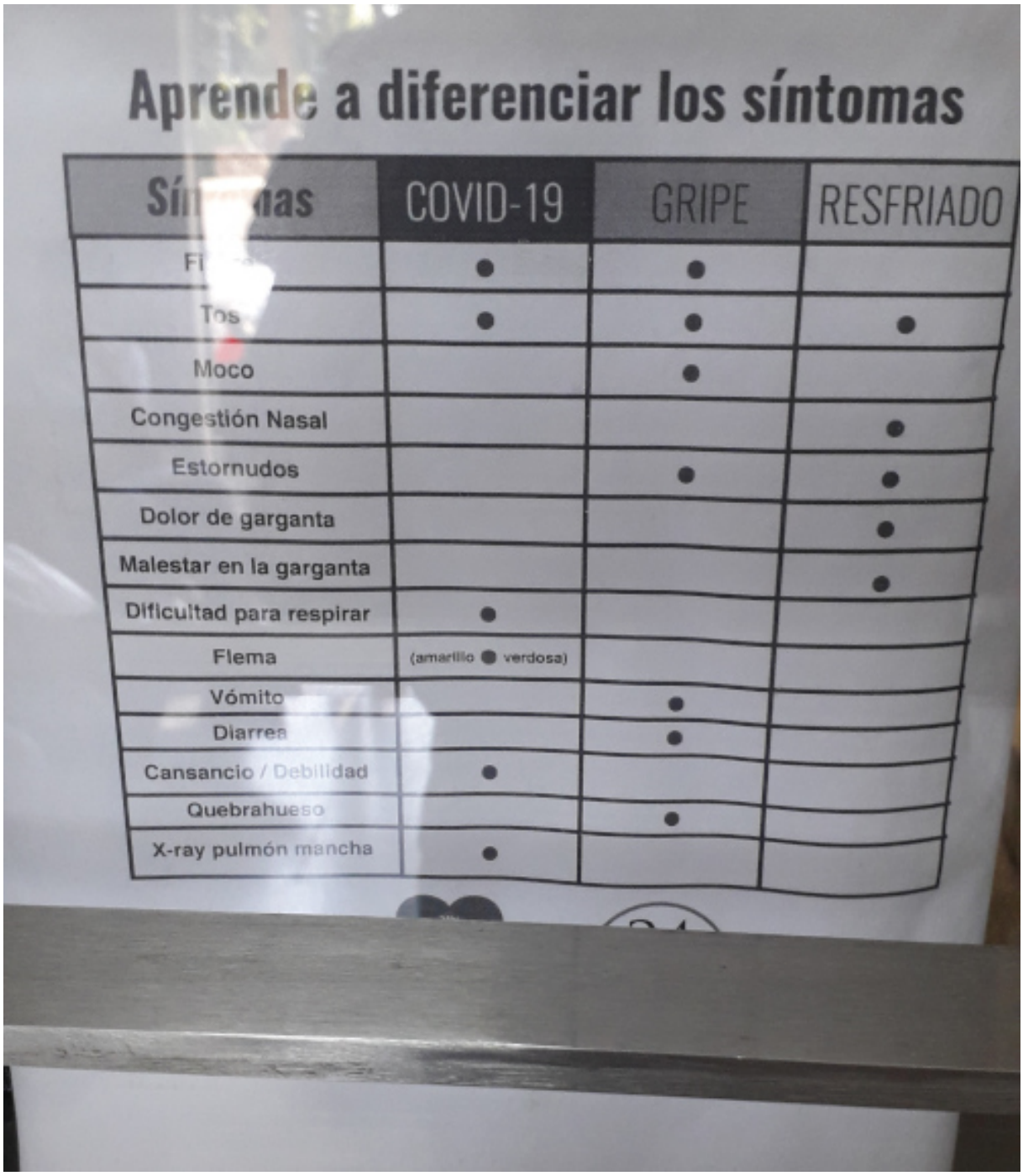


Foto tomada en la Guardia el 24 de marzo, cuando los enfermeros me mandaban a

buscar alguien que sepa usar la **Prueba** 4.3.4. Dificultad para respirar y el certificado de defunción dice: insuficiencia respiratoria aguda.

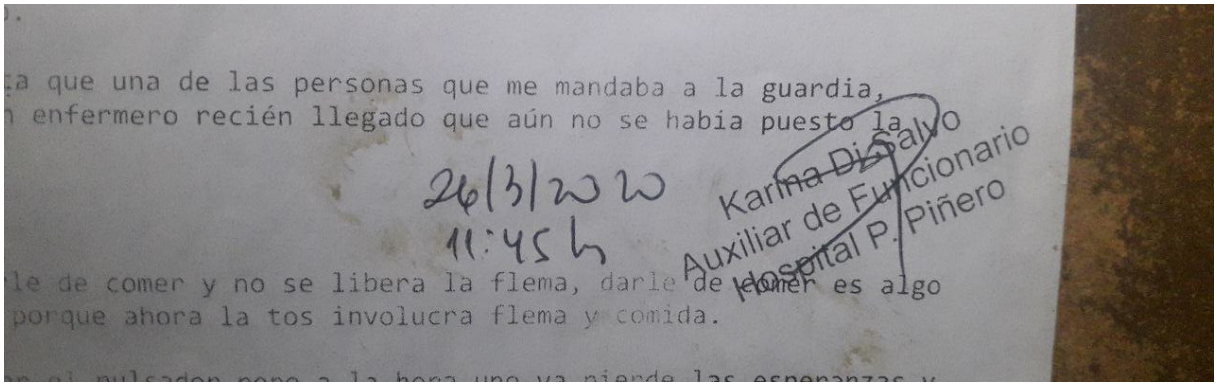
4.3.4. Aspersor de flema



Captura de pantalla de algun video del 25 de marzo. Ese aparato era para aspirar flema. Y con la foto de la guardia en **Prueba** 4.3.3, pienso: que casualidad, flema y aspersor de flema.

4.3.5. Nota a la Dirección del Piñero

Aunque la Historia Clínica incluye la nota dejada en el libro de quejas ¿es normal que agreguen esas cosas?. Curiosamente no incluye esta otra nota.

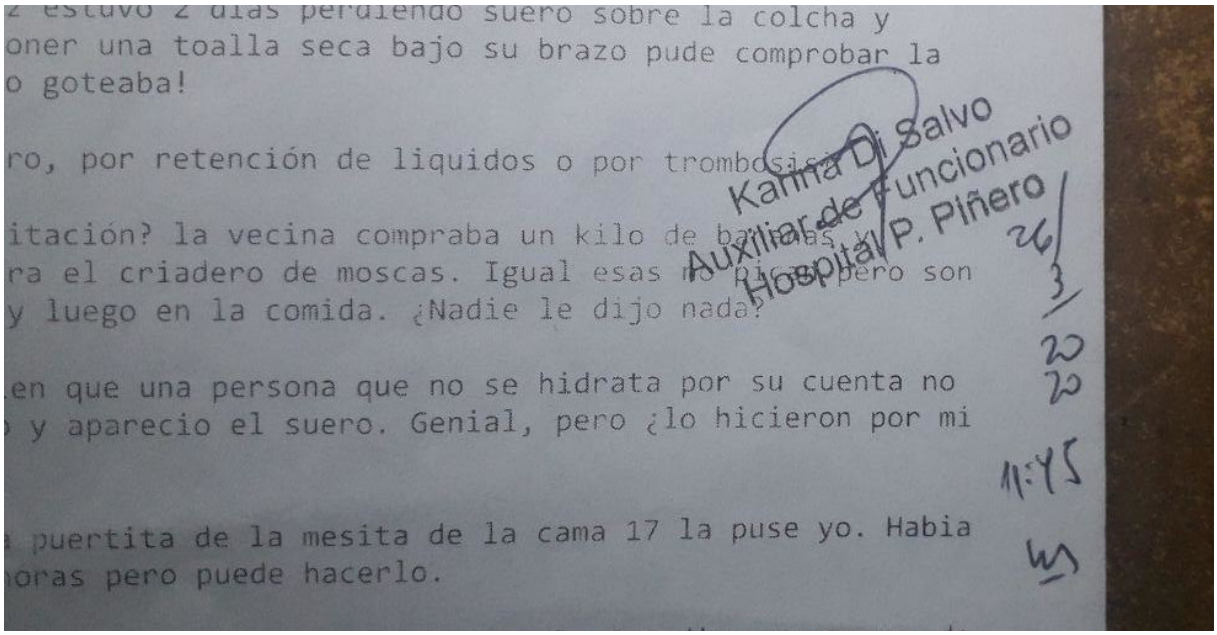


ta que una de las personas que me mandaba a la guardia,
n enfermero recién llegado que aún no se habia puesto la

26/3/2020
11:45 h

Karina Di Salvo
Auxiliar de Funcionario
Hospital P. Piñero

le de comer y no se libera la flema, darle de comer es algo
porque ahora la tos involucra flema y comida.



z estuvo 2 días perdiendo suero sobre la colcha y
oner una toalla seca bajo su brazo pude comprobar la
o goteaba!

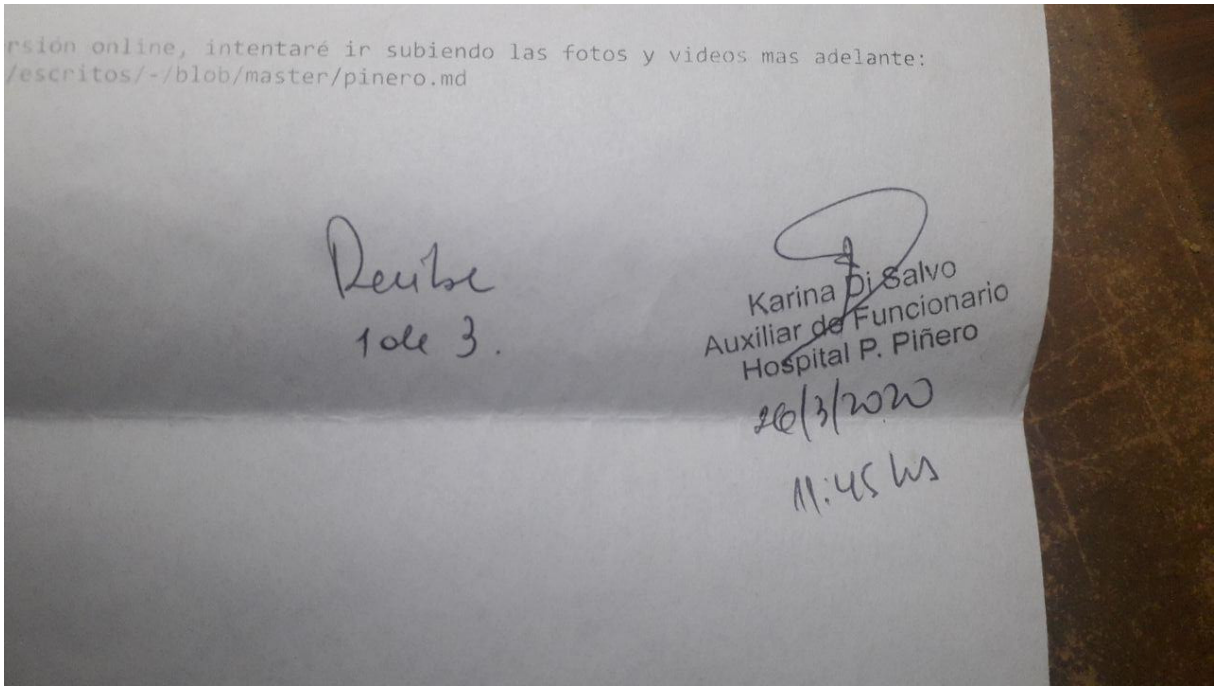
ro, por retención de liquidos o por trombosis?

itación? la vecina compraba un kilo de bananas y
ra el criadero de moscas. Igual esas no picaban pero son
y luego en la comida. ¿Nadie le dijo nada?

en que una persona que no se hidrata por su cuenta no
y aparecio el suero. Genial, pero ¿lo hicieron por mi

puertita de la mesita de la cama 17 la puse yo. Habia
oras pero puede hacerlo.

Karina Di Salvo
Auxiliar de Funcionario
Hospital P. Piñero
26/3/2020
11:45 h



4.3.6. Cambios en la sala

Daiana Artigue <dartigue@pami.org.ar> 29 de abril de 2020, 14:24
Para: Nicolas <nhk.web@gmail.com>

Deberían entregarte información detallada en el hospital, no pude comunicarme aún con el médico/a tratante que estuvo hoy porque hubo modificiaciones en la sala y el personal.
Lo que te puedo decir es que al momento en que se le asignó vacante en geriátrico estaba cursando un tratamiento antibiótico por infección, se tenía previsto que al momento de terminar ese tratamiento pudiera ser derivada. Sin embargo, el geriátrico ya había rechazado su ingreso.

Es todo lo que te puedo decir respecto del diagnóstico y motivo de defunción.

Página 4 del archivo mails-con-pami.pdf

4.3.7. Recepción denuncia

El 5 de mayo ya había número de denuncia

RECEPCION DENUNCIA MPF ×

Carlos Harari <carlos.harari@yahoo.com.ar> mar, 5 may 2020, 16:35

para mí, CARLOS, carlos

Estimado/a:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de funcionaria en ejercicio del turno de la Oficina Central Receptora de Denuncias, dependiente de la Secretaría de Acceso a Justicia del Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de informarle que se ha recibido su denuncia, la cual quedó registrada en el sistema informático KIWI bajo DENUNCIA Nº 632469.

En tal sentido informo que, la Unidad de Intervención Temprana, de la Unidad Fiscal Oeste, sita en la Av. Paseo Colon Nº 1333, se pondrán en contacto con usted durante los próximos días hábiles, en el horario comprendido entre las 09.00 a 15.00 horas.

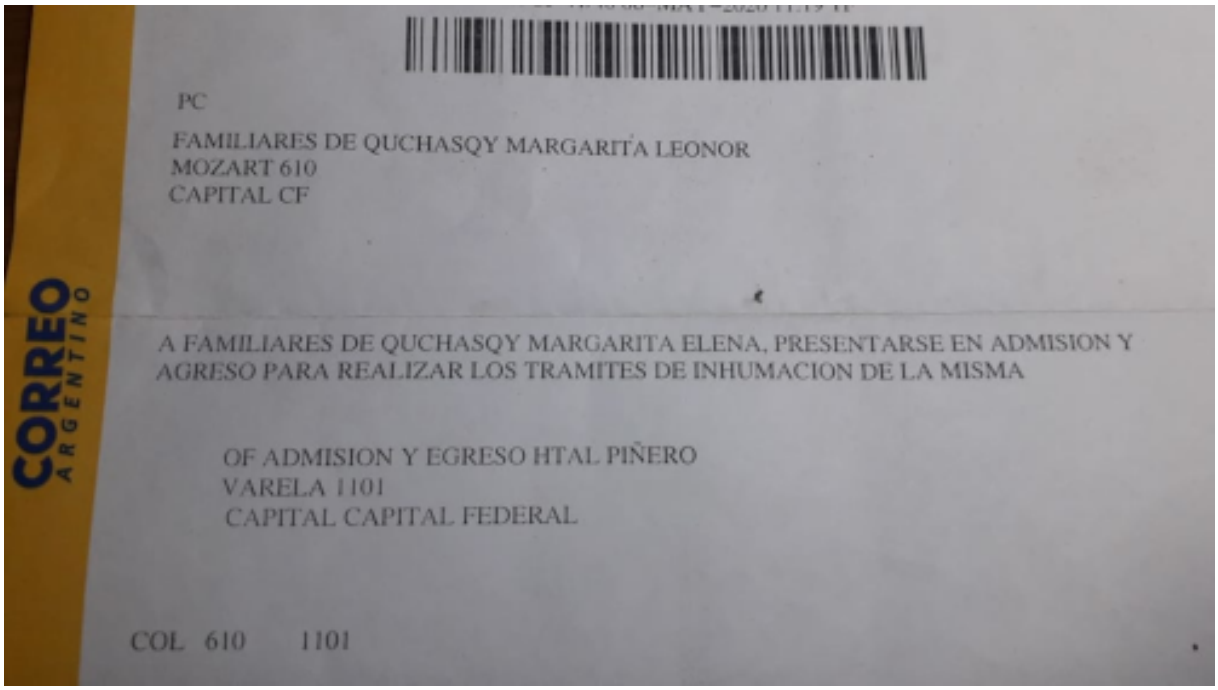
Ante cualquier evento, o hecho nuevo que desee denunciar, se podrá comunicar con la LINEA GRATUITA 0800 33 347225 (fiscal) donde personal de esta oficina, atiende las 24 hs. y los 365 días del año; o podrá efectuar su exposición personalmente recibiendo asesoramiento gratuito en la Unidad de Orientación y Denuncias (UOD) más cercana a su domicilio (pudiendo consultar ello en la web oficial https://www.fiscalias.gob.ar).

Por otro lado, podrá proceder de igual manera, a través de la dirección de correo electrónico denuncias@fiscalias.gob.ar; o bien, realizar la denuncia por medio de la página https://www.fiscalias.gob.ar.

Saludos cordiales.

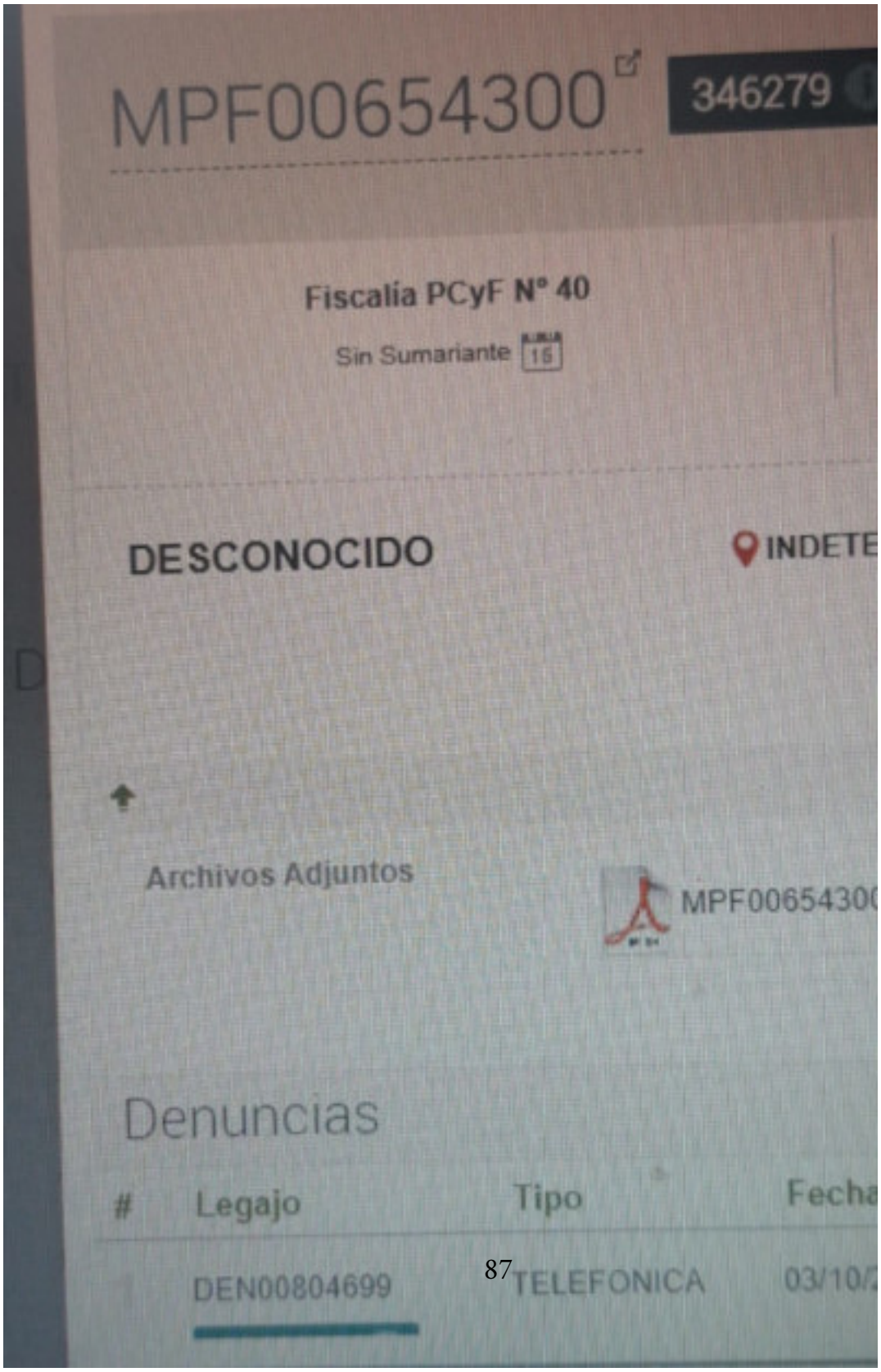
Pablo Galli
Secretario
Oficina Central Receptora de Denuncias

4.3.8. Telegrama



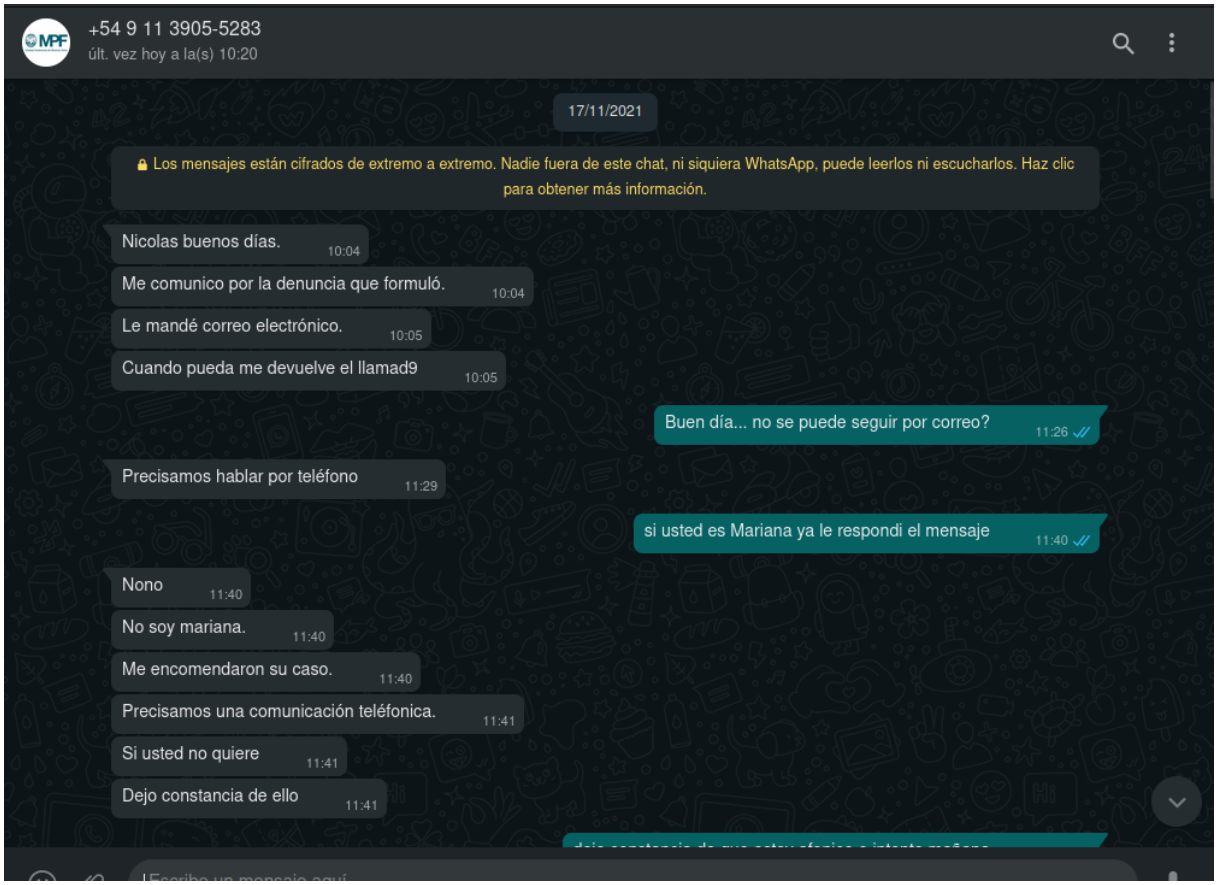
Mal el apellido, en un lugar Elena y en otro Leonor. El investigador del MPF concluyo que mi madre se llamaba Margarita Eleonor. Y la dirección correcta es 1301, como para que no les lleguen cartas documentos de respuesta.

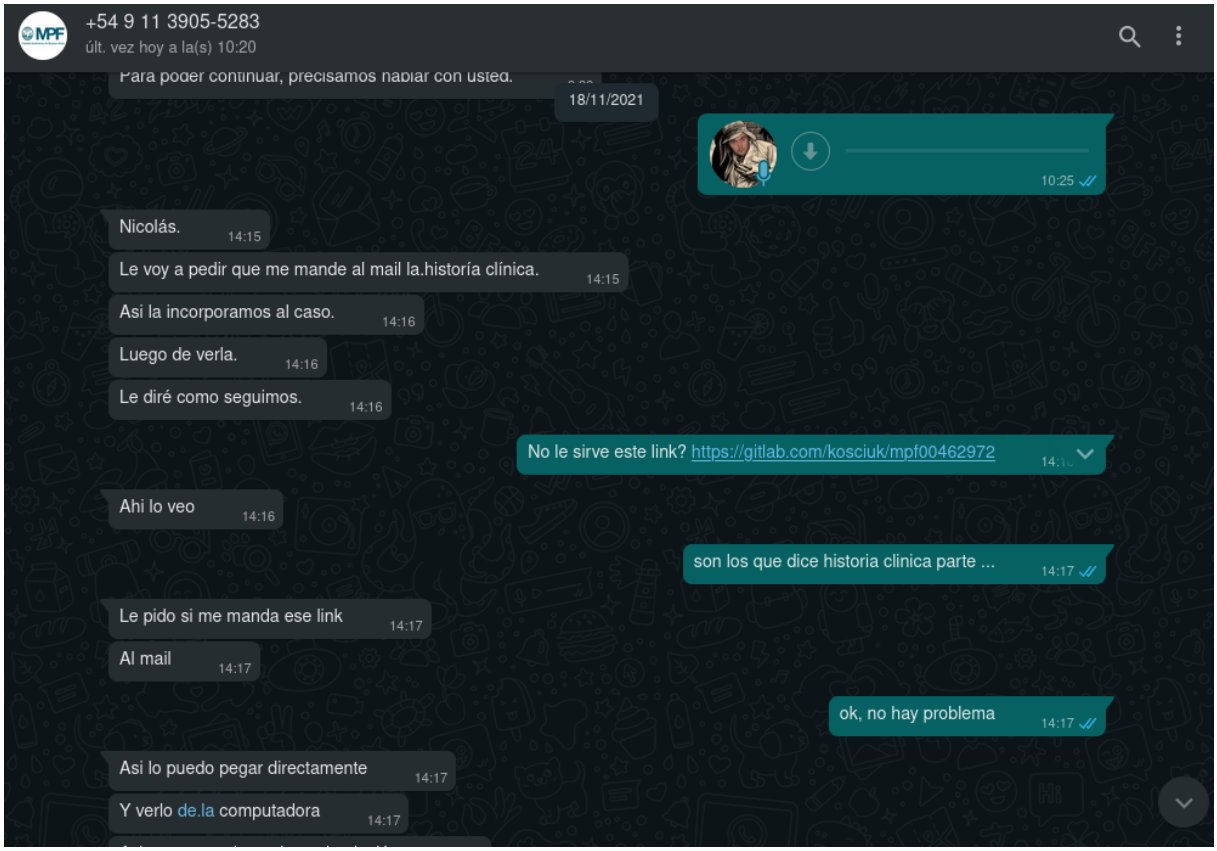
4.3.9. Portada denuncia MPF654300

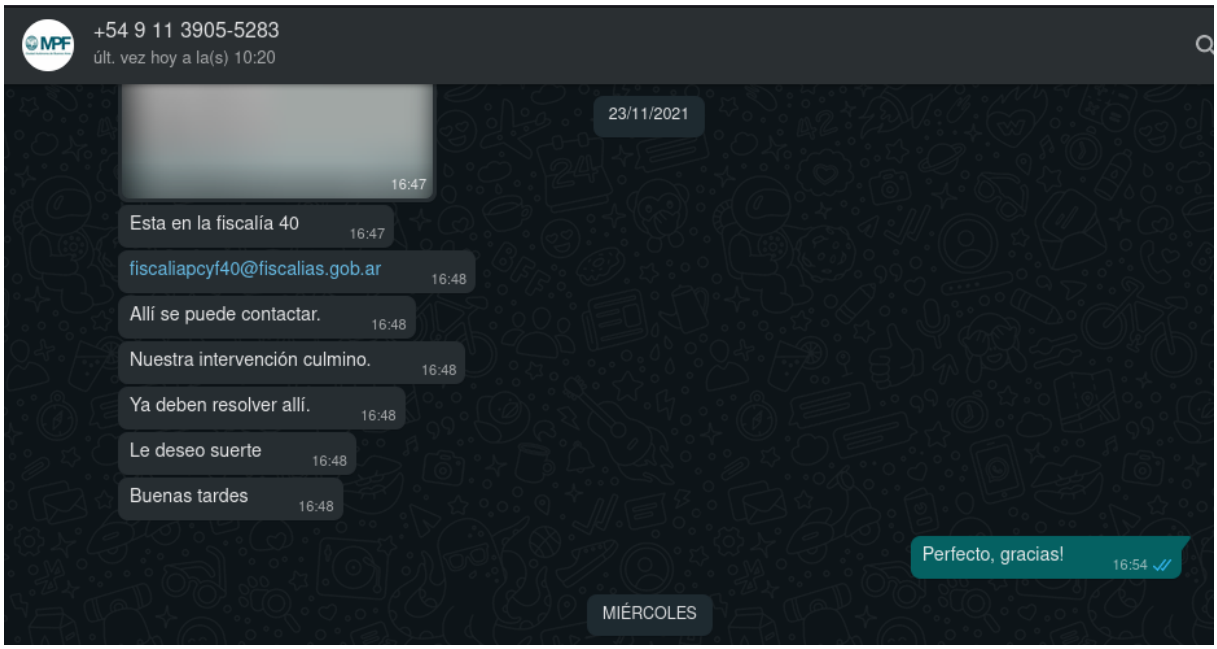


Es raro que la denuncia sea telefónica ya que yo enviaba todos los dias la misma denuncia por email, con copia a varios organismos que supuestamente defienden a las victimas, como el CENAVID.

4.3.10. Infiltrado UIT Sur

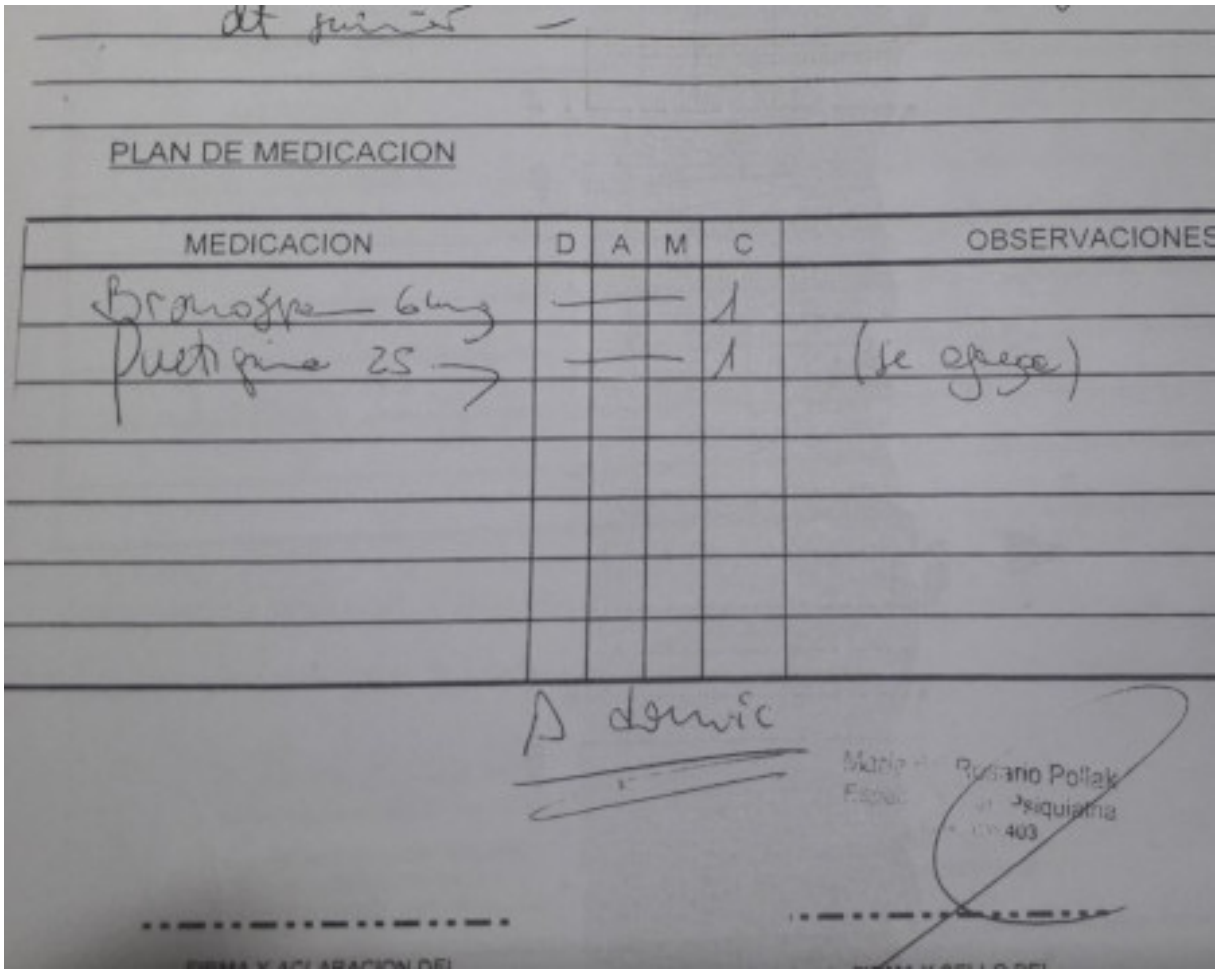



+54 9 11 3905-5283
últ. vez hoy a la(s) 10:20
Para poder continuar, precisamos hablar con usted.
18/11/2021
10:25
Nicolás. 14:15
Le voy a pedir que me mande al mail la.historía clínica. 14:15
Asi la incorporamos al caso. 14:16
Luego de verla. 14:16
Le diré como seguimos. 14:16
No le sirve este link? https://gitlab.com/kosciuk/mpf00462972
Ahi lo veo 14:16
son los que dice historia clinica parte ... 14:17
Le pido si me manda ese link 14:17
Al mail 14:17
ok, no hay problema 14:17
Asi lo puedo pegar directamente 14:17
Y verlo de.la computadora 14:17


+54 9 11 3905-5283
últ. vez hoy a la(s) 10:20
23/11/2021
16:47
Esta en la fiscalía 40 16:47
fiscaliapcyf40@fiscalias.gob.ar 16:48
Allí se puede contactar. 16:48
Nuestra intervención culmino. 16:48
Ya deben resolver allí. 16:48
Le deseo suerte 16:48
Buenas tardes 16:48
Perfecto, gracias! 16:54
MIÉRCOLES

Esta imagen borroneada es la foto que me paso la UIT Sur y se ve en la Prueba 4.3.9

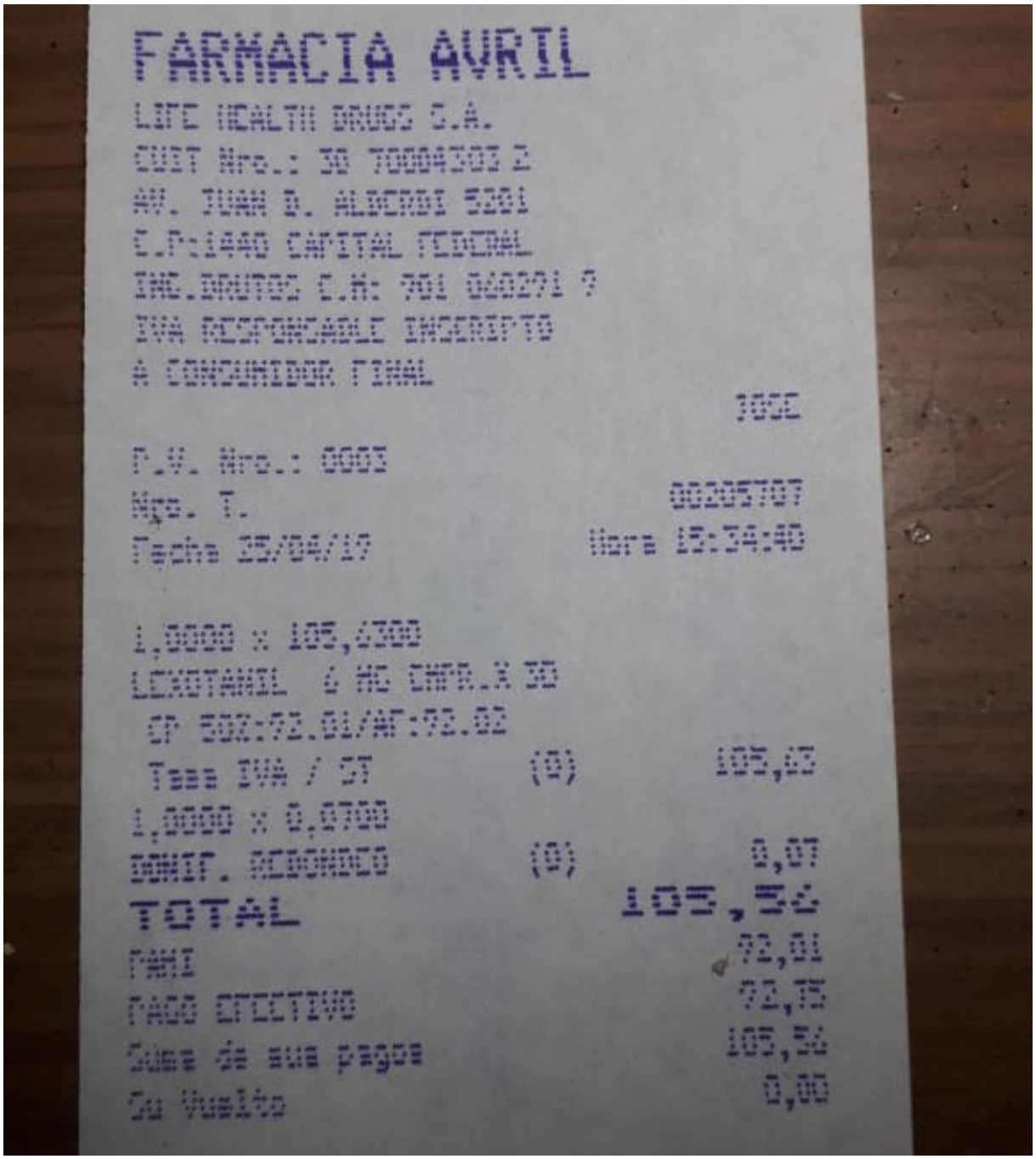
4.3.11. Medicación siquiatrica


PLAN DE MEDICACION

MEDICACION	D	A	M	C	OBSERVACIONES
Bromazepam 6mg	—			1	
Quetiapina 25	—			1	(se agrega)

El primer item es el Bromazepam, marca Lexotanil. La foto pertenece a la HC de Siquiatria Foja 5 con fecha 3 de diciembre de 2019.

4.3.12. Compras de Lexotanil



FARMACIA AVRIL
LIFE HEALTH DRUGS S.A.
CUIT Nro.: 30 70004303 2
AV. JUAN B. ALBERDI 5201
C.P:1440 CAPITAL FEDERAL
ING.BRUTOS C.M: 701 040271 7
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

TOZZ

P.V. Nro.: 0003
Nro. T. 00205707
Fecha 23/04/19 Hora 15:34:40

1,0000 x 105,4300
LEXOTANIL C MS CMPR.X 30
CF 502:72.01/AF:72.02
Tasa IVA / ST (0) 105,43
1,0000 x 0,0700
DEBIT. RG1000/20 (0) 0,07
TOTAL 105,50
EFECTIVO 72,01
PAGO EFECTIVO 72,75
Suma de sus pagos 105,50
Su Vuelto 0,00



Se intenta demostrar que el Lexotanil (la benzodiacepina) era algo que era tomado

con anterioridad, se compraba con recetas de PAMI y no era algo que hubiese receta o indicado yo.

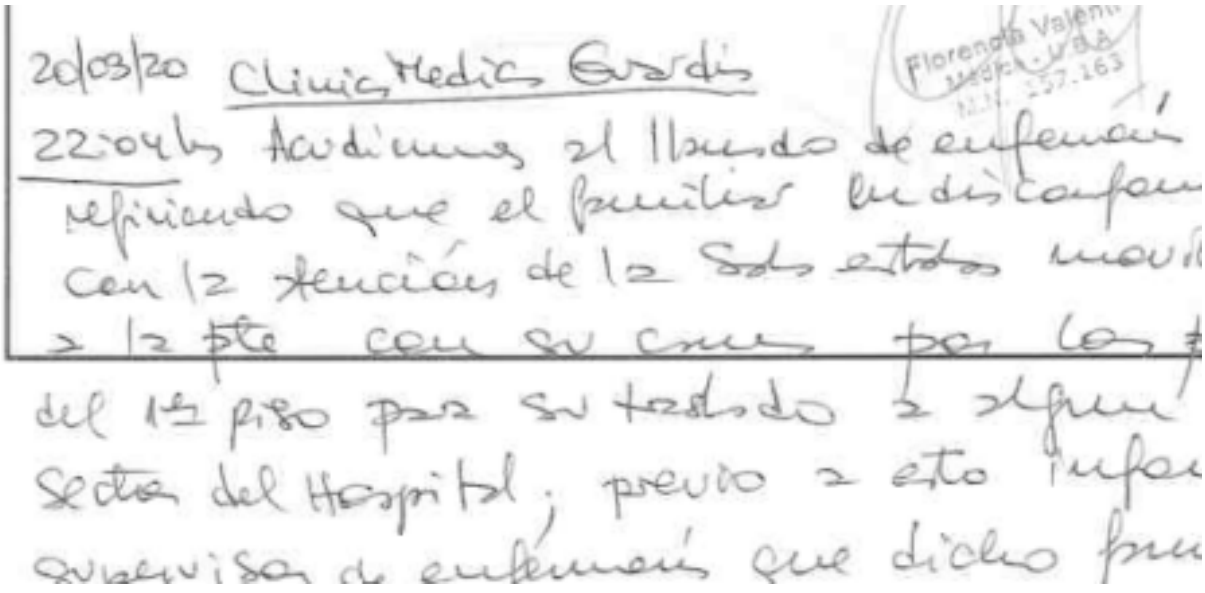
4.3.13. Inmovilidad



Tenerla postrada era decisión de los médicos, ni siquiera querían facilitarme una silla de ruedas para sacarla a pasear como me recomendaban los enfermeros.

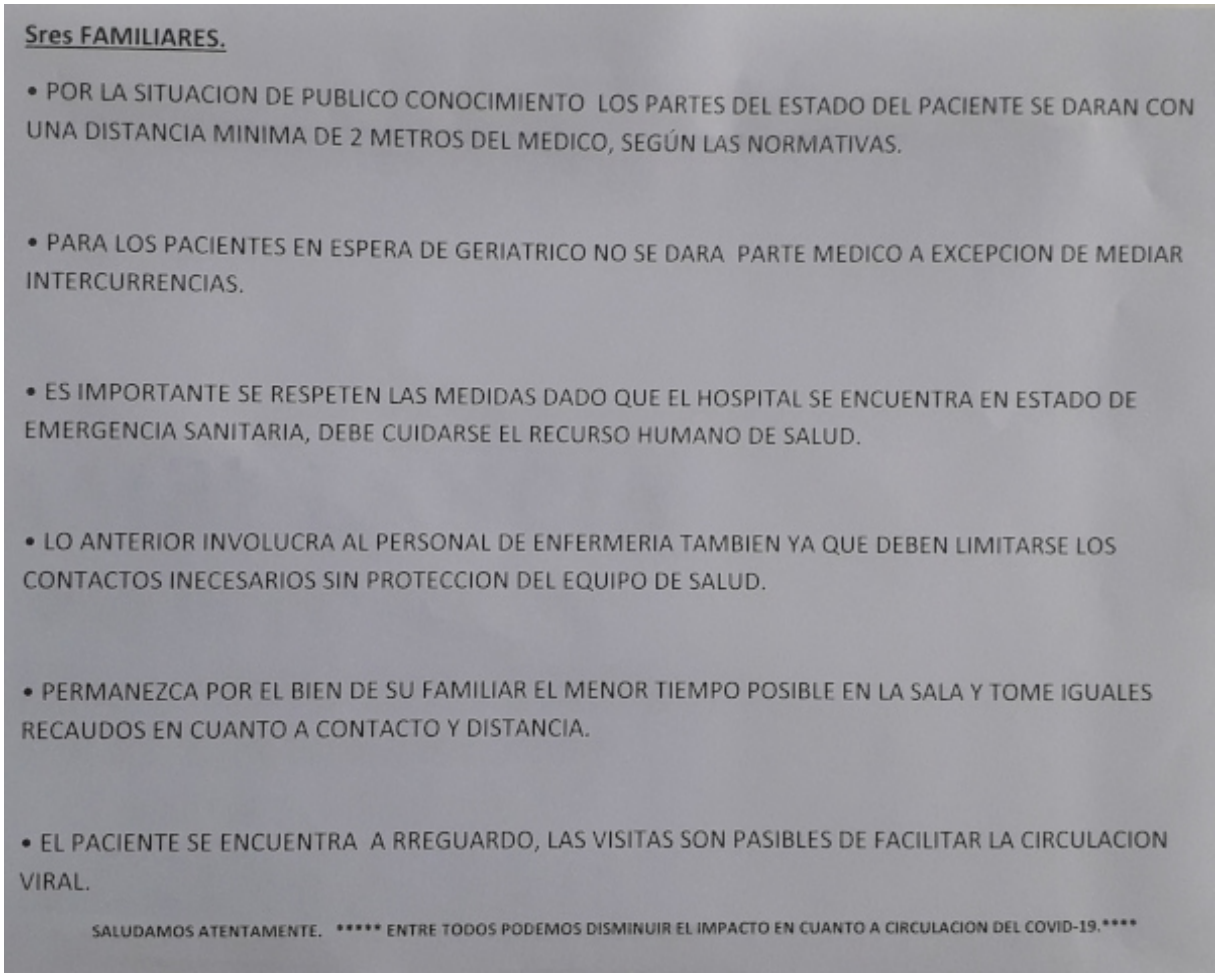
Como en las veces previas de internaciones prolongadas, pancreatitis y perdida de sodio, durante los primeros días tiene que volver a aprender a caminar. Imagino que eso debe tener un nombre en medicina.

4.3.14. Viaje a la Guardia


20/03/20 Clínica Médica Guardia
22:04 hs Acudimos al llamado de enfermería
refiriendo que el paciente se distanció
con la silla de la Sala estaba movi
a la pte con su cama por los
del 1er piso para su traslado a alguna
Sector del Hospital; previo a esto infor
supervisora de enfermería que dicho pa

Prueba de que llamaron a la Guardia porque dije que iba a llevarla a la Guardia.

4.3.15. Limitaciones COVID



Sres FAMILIARES.

• POR LA SITUACION DE PUBLICO CONOCIMIENTO LOS PARTES DEL ESTADO DEL PACIENTE SE DARAN CON UNA DISTANCIA MINIMA DE 2 METROS DEL MEDICO, SEGÚN LAS NORMATIVAS.

• PARA LOS PACIENTES EN ESPERA DE GERIATRICO NO SE DARA PARTE MEDICO A EXCEPCION DE MEDIAR INTERCURRENCIAS.

• ES IMPORTANTE SE RESPETEN LAS MEDIDAS DADO QUE EL HOSPITAL SE ENCUENTRA EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA, DEBE CUIDARSE EL RECURSO HUMANO DE SALUD.

• LO ANTERIOR INVOLUCRA AL PERSONAL DE ENFERMERIA TAMBIEN YA QUE DEBEN LIMITARSE LOS CONTACTOS INECESARIOS SIN PROTECCION DEL EQUIPO DE SALUD.

• PERMANEZCA POR EL BIEN DE SU FAMILIAR EL MENOR TIEMPO POSIBLE EN LA SALA Y TOME IGUALES RECAUDOS EN CUANTO A CONTACTO Y DISTANCIA.

• EL PACIENTE SE ENCUENTRA A RREGUARDO, LAS VISITAS SON PASIBLES DE FACILITAR LA CIRCULACION VIRAL.

SALUDAMOS ATENTAMENTE. ***** ENTRE TODOS PODEMOS DISMINUIR EL IMPACTO EN CUANTO A CIRCULACION DEL COVID-19.****

Foto de cartel pegado en puerta de la Sala 1 tomada el 24 de marzo de 2020.

A los familiares de pacientes esperando geriátrico tampoco le daban partes antes del COVID.

4.3.16. Negación del expediente

El lun., 27 jul. 2020 a las 13:54, Rodrigo Branca (<RBranca@fiscalias.gob.ar>) escribió:

> Estimado Dr. Harari, le hago saber POSF Dr. Juan Rozas, que el presente caso se encuentra digitalizado en su totalidad debido al ASPO y el mismo se le ha remitido a usted y al Sr. Kosciuk oportunamente por correo electrónico, careciendo de otras actuaciones que las ya remitidas.

Lo que tenía que hacer la Fiscalia, era comprimir una carpeta y enviarla por We-Transfer. Dos minutos de trabajo.

4.3.17. Permisos familiares

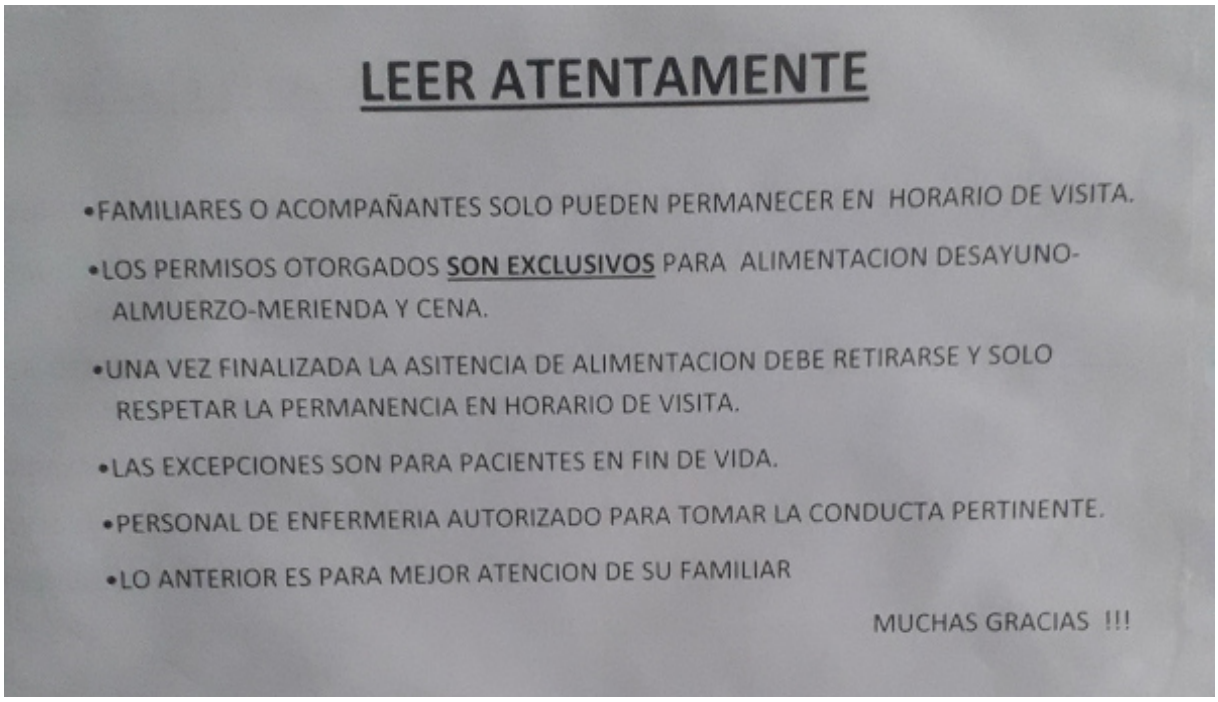
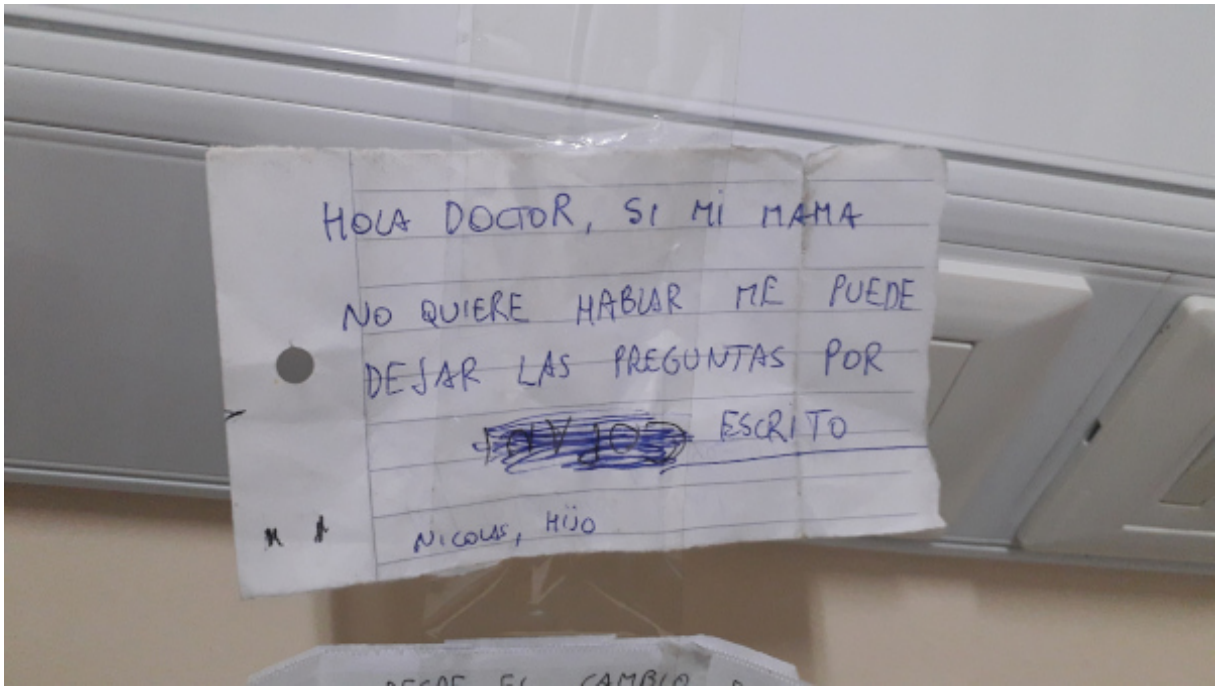


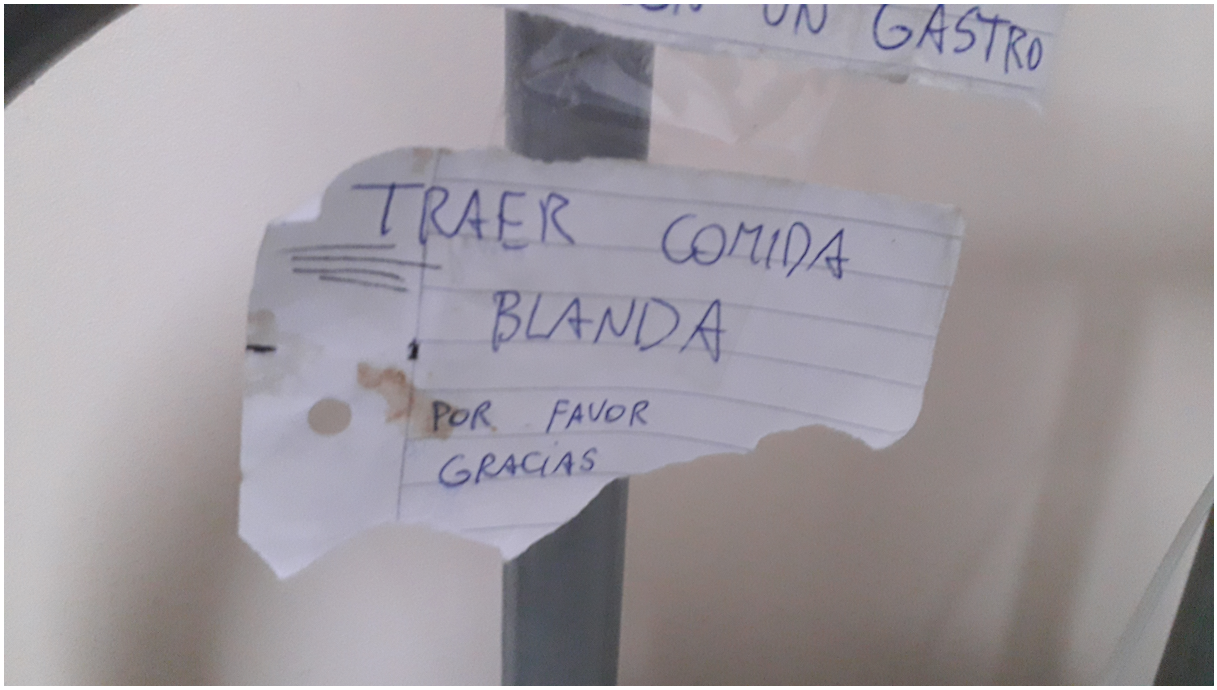
Foto del 13 de julio de 2020. No se desde cuando estaria pegada pero demuestra que habiendo enfermeros, los familiares seguian teniendo la obligación de ir a alimentar al familiar internado.

Lo de las excepciones, en teoria podria haberseme aplicado a mi, pero nunca me

llamaron.

4.3.18. Notas a los médicos





Esta era mi forma de comunicación con los médicos.

4.4. Historia Clinica

Puede solicitarse copia a la Fiscalía 20 del Ministerio Público Fiscal de CABA o mejor aún, el original, para asegurarnos que sigue estando.

4.5. Historia Clinica del Prestador de PAMI de Siquiatria

Se adjunta Archivo **HCSiquiatria.pdf**. Con fecha 16 de enero de 2020[26] puede leerse que el médico que concurre al domicilio, hace referencia a que la paciente esta cursando una infección urinaria o pulmonar y que conviene hacer un laboratorio (esperar a que pase el cuadro clínico) para continuar el tratamiento.

[26] *Página 6 del Archivo* ***HCSiquiatria.pdf***

4.6. PDFs

MPF462972.pdf El expediente digitalizado por la denuncia de abandono de persona. Comprimido en un solo PDF para comodidad.

MPF494439.pdf Resoluciones de la denuncia de falso testimonio contra los médicos.

MPF497727.pdf Resolución donde el Dr. Schinocca me denuncia por amenazas telefónicas y comenta que a mi madre la movieron a una Sala de COVID. Se archivó sin investigar las supuestas amenazas.

MPF654300.pdf Denuncia de la que no sabe de que se trata pero hace 6 meses estan reclamando la Historia Clínica.

DEN641840.pdf La denuncia por "encubrimiento" recalificada como incumplimiento de los deberes de funcionario publico contra Rozas.

DEN713875.pdf Resoluciones relativas a mi denuncia del faltante de páginas en el MPF CABA.

HistoriaClinica.pdf La Historia Clínica unificada y separada del expediente MPF462972.

HCSiquiatria.pdf Copia de la Historia Clínica del prestador siquiátrico obtenida por mi.

mails-con-defensoria.pdf Intercambio de mails con Defensoría.

mails-con-pami.pdf Intercambios de mails con el Centro Coordinador de PAMI. Hice denuncia en UFI-PAMI y quedó registrada con número 65973/2021 AC.

5. SOLICITO

- Se solicite al Ministerio Público Fiscal de la CABA el expediente MPF654300, para saber que fue lo que realmente afirmaron el médico que me expulsó, la Jefa de ese médico, el Director y el Subdirector del Hospital Piñero.
- Se solicite al Hospital Piñero, Sector Farmacia, si tiene registros del medicamento entregado el 27 de diciembre de 2019.

- Investigar los movimientos de otros pacientes de la Unidad 1 hacia otras salas hasta el vacimiento total a fines de abril de 2020.